

TEMA 49



ADICCIONES: CONCEPTOS BÁSICOS.

LA LEY 5/2.002, DE 27 DE JUNIO SOBRE DROGODEPENDENCIAS Y OTROS TRASTORNOS ADICTIVOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PLAN DE ADICCIONES DE LA CIUDAD DE MADRID.

LA CARTA DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE ADICCIONES: DERECHOS Y RESPONSABILIDADES. SERVICIOS PRESTADOS. COMPROMISOS CON LA CIUDADANÍA.

ÍNDICE

0.- Introducción.	
1.- Adicciones: conceptos básicos.	
1.1.- Las sustancias. 1.2.- Etiología de las adicciones. 1.3.- Formas de consumo.	
2.- La Ley 5/2.002, de 27 de junio sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos.	
2.1.- Planteamientos básicos en drogodependencia. 2.2.- Reducción de la demanda a través de medidas preventivas. 2.3.- Asistencia e integración. 2.4.- Competencias de las Corporaciones Locales.	
3.- Plan de Adicciones de la Ciudad de Madrid, 2.022-2.026.	
3.1.- Marco normativo. 3.2.- Principios y criterios orientadores del Plan. 3.3.- Líneas estratégicas y objetivos. 3.4.- Prevención frente a los riesgos relacionados con las adicciones. 3.5.- Atención integral a adolescentes y jóvenes. 3.6.- Reducción de los riesgos y daños asociados a las adicciones. 3.7.- Tratamiento integral de las personas con adicciones. 3.8.- Atención y prevención de la adicción al juego. 3.9.- Coordinación y trabajo en red. 3.10.- Calidad y mejora continua.	
4.- Carta de Servicios del Instituto de Adicciones.	
4.1.- Derechos y responsabilidades de los usuarios. 4.2.- Servicios prestados. 4.3.- Compromisos con el ciudadano.	

0.- INTRODUCCIÓN.

La evolución de los consumos de drogas constituye en cada país un fenómeno dinámico, condicionado por múltiples factores de carácter social y económico, con origen y dimensiones tanto internacionales, como nacionales y locales. En todos estos ámbitos territoriales, el impacto que tiene el consumo de las distintas sustancias psicoactivas continúa siendo elevado, tanto en términos de sufrimiento e incapacitación personal, como de morbilidad, mortalidad y otros costes sociales y sanitarios.

Además de los factores socioeconómicos que afectan a las tendencias globales del consumo de drogas, en el desarrollo de la adicción a las diversas sustancias psicoactivas influyen otros condicionantes, entre los que cabe señalar las características biológicas o la función psicológica instrumental que cada persona atribuye a una sustancia concreta en el marco de su estilo de vida particular. De igual modo, hay que considerar la evolución de los valores culturales que tienen que ver con las conductas adictivas y de consumo en general.

En consecuencia, cualquier intervención que aspire a mejorar significativamente esta situación debe necesariamente abordarse desde planteamientos estratégicos integrales, desarrollados en cada uno de los distintos contextos institucionales y territoriales.

Durante el último **Plan de Adicciones de la Ciudad de Madrid 2017/21**, la media anual de pacientes atendidos fue de 7.766, los hombres fueron 6.055 y las mujeres fueron 1.711.

El **alcohol** supuso el mayor número de personas en tratamiento con una media anual de 2.733, los opiáceos ocupan el segundo lugar con una media de 1.841, los tratamientos por cocaína son 1.692, por cannabis son 1.132. Las adicciones sin sustancia representaron una media anual de 368 tratamientos con un aumento importante en el año 2020.

Los pacientes que al año solicitaron por primera vez tratamiento fueron 2.089. La adicción que generó más pacientes nuevos es al alcohol con 835, le sigue la cocaína con 478 y después el cannabis con 427. Las adicciones sin sustancia generan 177 solicitudes de nuevos tratamientos, aunque en el año 2021 fueron 327.

En general, el número de personas tratadas ha permanecido constante con una ligera tendencia descendente, protagonizada por la **disminución de pacientes que solicitan tratamiento por opiáceos**. El resto de las adicciones se ha mantenido constante o con un ligero aumento, cabe destacar que la adicción que más pacientes supone es al alcohol.

A partir del año 2017 se comienza a registrar la presencia de la **violencia de género**. El porcentaje medio de víctimas es del 10,5% de las mujeres atendidas. Habiéndose producido un importante incremento en 2021.

El número de pacientes que acuden a los centros por **chemsex** se ha ido incrementando hasta llegar a su pico en el 2021 con 351 personas atendidas.

El distrito que más pacientes nuevos registra es el de **Puente de Vallecas** seguido por el de **Carabanchel**. En el número de personas que deciden solicitar tratamiento por segunda vez o más, es mayor en el distrito de Puente de Vallecas y seguido por el de Latina. Respecto al número total de personas que realizan tratamiento el distrito que más tiene es el de **Puente de Vallecas**, seguido por el de Latina y después el de Ciudad Lineal.

El programa de prevención va dirigido a adolescentes y jóvenes hasta 24 años. Las intervenciones con jóvenes en riesgo tuvieron una media anual de 1231. Siendo mayor el número de hombres 887 que de mujeres 344.

Los tratamientos en **adolescentes y jóvenes** con criterio de adicción tuvieron una media anual de 703. Del mismo modo, fueron más los hombres 549 que las mujeres 154.

La sustancia que más intervenciones, en adolescentes y jóvenes en riesgo, es el cannabis seguida del alcohol. En lo que respecta a adolescentes y jóvenes que han desarrollado una adicción la que más solicitudes de tratamiento recibe es, al igual que en el apartado anterior, el cánnabis, seguida por el alcohol. Parece importante resaltar que la adicción a la cocaína se equipara prácticamente al alcohol.

Resumiendo, los adolescentes y jóvenes atendidos por estar en riesgo de desarrollar una adicción son chicos que acuden por cannabis o alcohol. En este grupo estarían incluidos los que acuden al centro como consecuencia de una sanción administrativa por consumo y que pueden suspenderse por recibir atención en el CAD. Los que han desarrollado una adicción suelen ser varones con adicción a cannabis, aunque también acuden por alcohol o cocaína.

1.- ADICCIONES: CONCEPTOS BÁSICOS.

1.1.- LAS SUSTANCIAS.

Existen muchas sustancias y muchas formas de exponerlas y clasificarlas atendiendo a diferentes criterios: sus efectos, su situación legal, su peligrosidad... En este apartado hemos seleccionado las drogas de consumo más frecuente en nuestra sociedad y las hemos clasificado, atendiendo a sus efectos, según las principales familias a las que pertenecen.

DEPRESORAS: atenúan o inhiben los mecanismos cerebrales de la vigilia y pueden provocar, dependiendo de la dosis administrada, diferentes grados de inactivación (relajación, sedación, somnolencia, sueño, anestesia e incluso coma).

- Alcohol
- Barbitúricos
- Benzodiacepinas
- Derivados del Cannabis
- GHB
- Heroína
- Metadona
- Popper
- Sustancias volátiles

ESTIMULANTES: sustancias que producen sensación de euforia y bienestar, aumento de la energía y del nivel de actividad motriz, estimulación del sistema cardiovascular, disminución de la sensación de fatiga, del sueño y del apetito.

- Anfetaminas
- Cocaína
- Crack
- Drogas de síntesis
- Tabaco
- Xantinas: cafeína, teína, cacao

PERTURBADORAS: denominadas también alucinógenos, son sustancias que alteran el estado de conciencia y la percepción de la realidad provocando extrañas sensaciones, ilusiones y alucinaciones visuales, auditivas, táctiles...

- Derivados del Cannabis
- Drogas de síntesis
- Hongos
- Ketamina
- LSD
- Polvo de ángel
- Sustancias volátiles

1.2.- ETIOLOGÍA DE LAS ADICCIONES.

El fenómeno de las drogodependencias es de **etiología multifactorial**, donde las variables biológicas y psicológicas de los sujetos, así como las características de la organización social en la que se hallan inmersos están interactuando estrechamente. Esta interrelación se expresa gráficamente a través del conocido triángulo, en cuyos vértices se sitúan, con un mismo énfasis en cuanto a importancia, los tres elementos que intervienen en la configuración del fenómeno de las drogodependencias: la sustancia, la persona que la usa y el contexto.

Dependiendo de la priorización de uno de estos elementos aparecerán determinados enfoques terapéuticos. De todos ellos vamos a intentar hacer una clasificación lo más esquemática posible:

- ***Biologicista,*** considera la drogodependencia como enfermedad y los agentes que las producen son elementos que actúan por cuenta propia, al margen del contexto social y los comportamientos del sujeto implicado.
- ***Psicologicista***, de corte funcionalista, es decir, es exclusivamente el individuo el responsable de un determinado estilo de vida anómico, culpabilizando al mismo si no consigue salir del mundo de las drogas.
- ***Sociologista,*** responsabiliza a la sociedad, creyendo que el hombre es una víctima indefensa de una sociedad opresora, alienante e injusta. Los programas irían dirigidos a modificar exclusivamente el contexto social.
- ***Etico-Jurídica***, de corte moralista. La información va dirigida fundamentalmente a distinguir lo infensivo y lo peligroso desde el punto de vista del orden social. Las acciones son de tipo de modificación legal y represión de la distribución y tráfico de drogas.
- ***Integrador,*** la intervención es de carácter interdisciplinar e intersectorial, teniendo en cuenta todos los aspectos del fenómeno, por lo tanto, intervienen factores propios del **individuo**, otros relacionados con las influencias del **medio social**, y también con las características de la **droga** que determinan la rapidez con que puede desarrollarse la adicción.

Usando el esquema de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se puede plantear que el uso indebido de drogas y la drogadicción, se produce por la interacción entre los tres elementos -**modelo bio-psico-social**: el **individuo** (huésped), el **ambiente** (medio) y la **droga** (agente). Este modelo permite obtener una visión integral del problema, considerando cada uno de sus componentes y, en especial, la interacción entre ellos.

1.3.- FORMAS DE CONSUMO.

De igual manera existen también muchas formas de consumir estas sustancias, formas de las que dependerán los efectos y consecuencias posteriores al consumo, cuyo control será de vital importancia para reducir sus riesgos. Tienen que ver con:

- La cantidad de sustancia consumida
- La pureza de la dosis
- La frecuencia de consumo
- La vía de consumo: oral, fumada o inhalada, esnifada o inyectada
- La duración del consumo a lo largo del tiempo.

- Las situaciones de consumo: entorno y lugar de consumo, consumo en situaciones de especial riesgo (conducción, en tareas que requieren especial concentración o destreza, enfermedades, embarazo, mezcla de sustancias o mezcla con medicamentos...) o en situaciones en las que el consumidor, cada vez, les atribuye a las sustancias más significados o funciones en su vida.

Así podemos hablar de:

Consumos experimentales: Corresponden a las situaciones de contacto inicial con una o varias sustancias, de las cuales puede pasarse a un abandono de la misma o a la continuidad en los consumos. En la práctica totalidad de las realidades culturales, la adolescencia es la etapa en que con mayor frecuencia surgen este tipo de consumos, si bien un alto porcentaje no reincide en el mismo. Normalmente definen este tipo de consumo situaciones en las que el individuo desconoce los efectos de la sustancia y su consumo se realiza, generalmente, en el marco de un grupo que le invita a probarla.

Consumos ocasionales: Corresponden al uso intermitente de la sustancia, sin ninguna periodicidad fija y con largos intervalos de abstinencia.

El sujeto continúa utilizando la sustancia en grupo. Aunque es capaz de llevar a cabo las mismas actividades sin necesidad de mediar droga alguna, ya conoce la acción de la misma en su organismo y por este motivo la consume.

Consumos habituales: supone una utilización frecuente de la droga. Esta práctica puede conducirle a las otras formas de consumo, dependiendo de la sustancia que se trate, la asiduidad con que se emplee, las características de la persona, el entorno que le rodea, etc.

Algunos indicadores que definen esta forma de consumo son: el sujeto amplía las situaciones en las que recurre a las drogas. Éstas se usan tanto en grupo como de manera individual; sus efectos son perfectamente conocidos y buscados por el usuario.

Consumos compulsivos o drogodependencias: el individuo necesita la sustancia y toda su vida gira en torno a ésta a pesar de las complicaciones que ello le puede ocasionar.

Algunos indicadores de esta forma de consumo son:

- Utilización de la sustancia en mayor cantidad o por un periodo de tiempo más largo de lo que el consumidor pretendía.
- Toma de conciencia sobre la dificultad para controlar el uso de la droga.
- Empleo de la gran parte del tiempo en actividades relacionadas con la obtención de la sustancia y el consumo de la misma.
- Intoxicación frecuente o síntomas de abstinencia cuando el sujeto desempeña determinadas obligaciones.
- Reducción considerable o abandono de actividades sociales, laborales o recreativas.
- Uso continuado de la sustancia a pesar de ser consciente de los problemas que elle le está causando.
- Tolerancia frecuente.
- Con asiduidad se recurre a la sustancia para aliviar el malestar provocado por su falta.

2.- LA LEY 5/2.002, DE 27 DE JUNIO SOBRE DROGODEPENDENCIAS Y OTROS TRASTORNOS ADICTIVOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Las actuaciones que se desarrollan por la **Comunidad de Madrid** en materia de drogodependencias responden a los principios rectores que se enuncian en la Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid (LOSCAM, Ley 12/2.001, de 21 de diciembre).

LEY 5/2.002, DE 27 DE JUNIO, SOBRE DROGODEPENDENCIAS Y OTROS TRASTORNOS ADICTIVOS.
TÍTULO PRELIMINAR. Disposiciones generales.
TÍTULO I. De la reducción de la demanda a través de medidas preventivas. - Capítulo I. De la prevención de las drogodependencias y de otros trastornos adictivos. - Capítulo II. De la prevención escolar y comunitaria de las drogodependencias y de otros trastornos adictivos.
TÍTULO II. Asistencia e integración. - Capítulo I. Asistencia a drogodependientes. - Capítulo II. De los derechos y deberes de los pacientes. - Capítulo III. Del sistema de asistencia al drogodependiente. - Capítulo IV. Integración del drogodependiente. - Capítulo V. De los centros de asistencia e integración en el ámbito de las drogodependencias.
TÍTULO III. Del control de la oferta. - Capítulo I. De las limitaciones a la publicidad y promoción de bebidas alcohólicas y de tabaco. - Capítulo II. De las limitaciones a la venta y consumo de bebidas alcohólicas. - Capítulo III. De las limitaciones a la venta y consumo de tabaco. - Capítulo IV. Estupefacientes y psicótropos. - Capítulo V. Otras medidas.
TÍTULO IV. De la organización y competencias de las Administraciones Públicas.
TÍTULO V. De la financiación.
TÍTULO VI. Del régimen de infracciones y sanciones. - Capítulo I. De la inspección y medidas cautelares. - Capítulo II. De las infracciones y sanciones.

La Ley está formada por un Título Preliminar y 6 Títulos, 62 artículos, 3 disposiciones adicionales, 3 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 4 disposiciones finales.

OBJETO DE LA LEY.
La presente Ley tiene por objeto **regular, en el marco de las comparecencias que estatutariamente corresponden a la Comunidad de Madrid, las actuaciones e iniciativas en el campo de las drogodependencias y otros trastornos adictivos,** englobando las **áreas de prevención, asistencia, integración social, formación y evaluación,** así como las actuaciones tendentes a la **protección de terceras personas, ajenas al consumo de drogas y que, por esta causa, pudieran verse afectadas.**
ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY.
Las disposiciones contenidas en la presente Ley serán de aplicación a las diferentes actuaciones, tanto individuales como colectivas, ya sean de carácter público o privado, que en materia de drogodependencias y otros trastornos adictivos se desarrollen en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.
DESTINATARIOS.
Se entiende por tales **todos los españoles residentes o transeúntes en la Comunidad de Madrid**, así como los **extranjeros inscritos en el Padrón del municipio de la Comunidad de Madrid** en que residan habitualmente, en las mismas condiciones que los españoles. Asimismo, los **extranjeros que acudan los Servicios o Centros en situaciones de urgencia, las extranjeras embarazadas durante el período de embarazo, parto y posparto y los extranjeros menores de edad** en las mismas condiciones que los españoles. En todo caso, las administraciones prestarán una especial atención al ámbito de la **infancia y la adolescencia** en relación con las drogodependencias y otros trastornos adictivos.

2.1.- PLANTEAMIENTOS BÁSICOS EN DROGODEPENDENCIAS.

El Pleno de la Asamblea de Madrid aprobó el 20 de junio de 2.002 la **Ley sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos**. Nos encontramos ante la primera Ley que la Comunidad de Madrid aprueba de forma específica sobre la cuestión de las drogodependencias y recogemos, de su exposición de motivos la descripción que se realiza de la realidad del consumo de drogas en nuestra Comunidad.

1.- Se comienza con la afirmación de que el consumo de drogas es un **fenómeno complejo y cambiante**, y que se ha convertido en uno de los problemas que genera mayor preocupación social. Las drogodependencias, junto a otros **trastornos adictivos**, generan graves trastornos a nivel familiar, social y económico.

2.- Respecto a las drogas (heroína, cocaína, cannabis, drogas de síntesis, alcohol y tabaco ...), su extendido consumo ha provocado un nuevo fenómeno social y cultural sin precedentes, definido por la **falsa creencia de la inocuidad de las sustancias** y por la **dificultad legal de perseguir nuevas sustancias** no reconocidas legalmente como drogas en el momento de su síntesis.

3.- Se señala que la Comunidad de Madrid, al contener la Capital del Estado y tener gran parte de su territorio el **carácter de urbano**, vive el fenómeno de las drogodependencias y otros trastornos adictivos con mayor intensidad. En nuestra Comunidad hay un número importante de muertes por sobredosis, de casos de Sida (asociados a consumos por vía parenteral) y de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas.

4.- Frente a visiones parciales –que suponen intervenciones parciales- es importante abordar esta cuestión desde un **enfoque global**, que concibe estas adicciones como un **desajuste biopsicosocial** y garantice la **coordinación entre todos los recursos asistenciales especializados y los recursos de la red público sociosanitaria.**

A los efectos de la Ley se considera droga **"toda aquella sustancia que, introducida en un organismo vivo, puede modificar una o más de las funciones de éste, siendo capaz de generar dependencia, provocar cambios en la conducta y efectos nocivos para la salud y el bienestar social"**. Tienen, según la Ley 5/2.002, la consideración de drogas las siguientes sustancias: bebidas alcohólicas (de graduación superior a 1 grado porcentual de su volumen), tabaco, productos de uso industrial (inhalantes y colas), ... y cualquier otra sustancia que se incluya en la definición general ya citada.

Y, dentro del marco de la Ley, se recogen los siguientes **conceptos**:

Trastorno adictivo.	Patrón desadaptativo de comportamiento que provoca un trastorno psíquico, físico o de ambos tipos, por abuso de sustancias o conducta determinada, repercutiendo negativamente en las esferas psicológica, física y social de la persona y su entorno.
Drogodependencia.	Trastorno adictivo definido como aquel estado psíquico, y a veces físico y social, causado por la acción recíproca entre un organismo vivo y una droga, que se caracteriza por modificaciones en el comportamiento y por otras reacciones que comprenden siempre un impulso irreprimible por consumir una droga en forma continuada o periódica, a fin de experimentar sus efectos psíquicos y físicos y, a veces, para evitar el malestar producido por su privación.
Drogodependiente.	Se entiende por tal aquella persona que sufre drogodependencia.
Prevención.	Conjunto de actuaciones encaminadas a eliminar o modificar los factores de riesgo y a fomentar factores de protección frente al consumo de drogas, o a otras conductas adictivas, con la finalidad de evitar que éstas se produzcan, se retrase su inicio, o bien que no se conviertan en un problema para la persona o su entorno social.
Tratamiento.	Conjunto de medidas de toda clase: físicas, higiénicas, biomédicas, farmacéuticas, psicológicas y quirúrgicas, que se ponen en práctica para la curación o alivio de las enfermedades.
Desintoxicación.	Proceso terapéutico orientado a la interrupción de la intoxicación producida por una sustancia exógena al organismo.
Deshabituación.	Proceso orientado al aprendizaje de habilidades que permitan al drogodependiente enfrentarse a los problemas asociados al consumo de drogas, con el objetivo final de eliminar su dependencia de las mismas.
Rehabilitación.	Proceso en el que el uso combinado y coordinado de medidas médicas, sociales y educativas, ayudan a los individuos a alcanzar los más altos niveles funcionales posibles e integrarse en la sociedad.
Integración.	Proceso de incorporación de una persona a su entorno habitual como ciudadano responsable y autónomo, en el que se incluyen tanto la recuperación de las capacidades individuales de integración social como los cambios sociales necesarios para la aceptación de las personas drogodependientes.

Reducción de daños y riesgos.	Estrategias de intervención dirigidas a disminuir los efectos especialmente negativos que pueden producir algunas formas del uso de drogas o de las patologías asociadas al mismo, así como otras estrategias de intervención orientadas a modificar las conductas susceptibles de aumentar los efectos especialmente graves para la salud asociados al uso de drogas.
Evaluación.	Análisis de los indicadores establecidos en relación a las actividades realizadas en la prevención, tratamiento e integración de los sujeto drogodependientes para la elección de las más adecuadas y el establecimiento de prioridades científico-técnicas, económicas o sociales.
Centros socio-sanitarios.	Aquellos que atienden a sectores de la población tales como personas mayores, personas con discapacidad y cualesquiera otros cuyas condiciones de salud requieran, además de las atenciones sociales que les presta el centro, determinada asistencia sanitaria.

En materia de drogodependencias, las Administraciones Públicas actuarán conforme a los siguientes **principios:**

a. **Responsabilidad pública y coordinación institucional** de actuaciones.

b. **Descentralización, responsabilidad, equidad y autonomía en la gestión de los programas y servicios**.

c. **Participación activa de la comunidad y de los propios afectados** en el impulso y ejecución de las políticas de actuación.

- La Comunidad de Madrid intervendrá sobre las **condiciones ambientales y socioculturales** que inciden como factores de riesgo en el consumo de sustancias capaces de generar dependencia.
- La **promoción activa de hábitos de vida saludables y de una cultura de salud** que incluya el rechazo al consumo de drogas, así como la modificación de actitudes y comportamientos de la sociedad respecto a las drogodependencias, generando una conciencia solidaria de apoyo y asistencia a las personas con problemas de drogodependencia.
- La consideración, a todos los efectos, de las drogodependencias y otros trastornos adictivos como **enfermedades comunes** con repercusiones en las **esferas biológica, psicológica y social de la persona.**
- La **consideración integral e interdisplinar del proceso continuado de la prevención de drogodependencias, asistencia e integración social del drogodependiente**, mediante la coordinación de diferentes actuaciones sectoriales y de las administraciones y entidades e instituciones, contando con la participación activa de la comunidad en la ejecución y control de las intervenciones destinadas a abordar los problemas relacionados con el consumo de drogas.
- La selección e implantación de las **actuaciones y programas en materia de drogas en el marco de la ordenación sanitaria y de acción social** de la Comunidad de Madrid, con sujeción a criterios de eficiencia y evaluación continua de resultados con la consideración prioritaria de las políticas y actuaciones preventivas en materia de drogodependencias.
- La aplicación del **principio de equidad en la salud** entendida como el derecho de todas las personas a disfrutar de igualdad de oportunidades en función de su necesidad para desarrollar y mantener su salud a través de un acceso igualitario a los servicios sin que exista discriminación alguna.

2.2.- REDUCCIÓN DE LA DEMANDA A TRAVÉS DE MEDIDAS PREVENTIVAS.

Las Administraciones Públicas **deben intervenir en las condiciones sociales y factores de riesgo que pueden favorecer el consumo de drogas** (especialmente entre niños y jóvenes). Habrán de desarrollar programas y actuaciones tendentes a:

a.- **Informar adecuada y oportunamente** a la población sobre las sustancias que puedan generar dependencia, sus características y consecuencias del abuso de las mismas de forma veraz y científicamente contrastada.

b.- **Educar para la salud**, potenciando hábitos saludables frente a las actitudes favorecedoras del consumo de drogas, al objeto de conseguir una **cultura de la salud** que incluya el rechazo a las drogas.

c.- **Formar profesionales** que actúen en el campo de la prevención de drogodependencias y otros trastornos adictivos.

d.- Promocionar **factores de protección** que incrementen valores preventivos respecto a las drogas y modifiquen las condiciones sociales y los factores de riesgo que puedan favorecer el consumo de drogas.

e.- **Modificar las percepciones, actitudes y comportamientos de la población** respecto a las drogodependencias y otros trastornos adictivos generando una conciencia social solidaria y participativa frente a este problema.

f.- Adoptar medidas que tiendan a **evitar los perjuicios para la salud** que se derivan del consumo de drogas, no sólo para los consumidores, sino para terceros ajenos al consumo de estas sustancias.

g.- Promover de forma prioritaria **acciones preventivas dirigidas a la población infantil, adolescente y de especial riesgo** en la Comunidad de Madrid.

h.- Potenciar la implantación y desarrollo de **programas de prevención comunitaria, educativa, familiar y laboral** necesarios para que las políticas de prevención de las drogodependencias sean efectivas.

i.- **Coordinar e impulsar las actividades** tendentes a prevenir el consumo de drogas entre las Administraciones Públicas, Organismos públicos, Movimiento Asociativo, así como los diferentes colectivos sociales implicados en esta problemática.

j.- Promover la formalización de acuerdos de **colaboración con organizaciones sindicales y empresariales**, a fin de promover la prevención en el ámbito laboral.

k.- Fomentar la formalización de convenios con **Organismos e Instituciones públicas, Universidades y Entidades sin ánimo de lucro** en materia de prevención de drogodependencias y otros trastornos adictivos.

l.- **Limitar la presencia, promoción y venta de drogas**.

m.- Fomentar **alternativas de ocio y tiempo libre** que conlleven la reducción de la atracción social sobre las drogas, así como la demanda de las mismas.

n.- Incidir especialmente en la **toma de conciencia de la sociedad madrileña sobre el carácter de drogas del alcohol y del tabaco.**

ñ.- Disponer de **sistemas de información** que garanticen el conocimiento permanente y la evolución de los patrones de consumo, así como la evaluación de las intervenciones realizadas.

o.- Fomentar el **movimiento asociativo juvenil,** favoreciendo la participación en programas culturales, de ocio, especialmente nocturno, deportivos, medioambientales, de educación para la salud y de apoyo a colectivos que viven en situación de riesgo social.

Los **ámbitos prioritarios de la prevención en drogodependencias y otros trastornos adictivos serán el comunitario, escolar, familiar y laboral**. La prevención se realizará mediante el desarrollo de actividades, en cuya elaboración podrán participar activamente las organizaciones y asociaciones sociales, cuyas iniciativas y actividades serán favorecidas por los poderes públicos.

- Las actuaciones desarrolladas en materia de prevención en drogodependencias y otros trastornos adictivos por las Administraciones Públicas, entidades privadas e instituciones, deberán enmarcar la **prevención en drogodependencias en un ámbito general de promoción y educación para la salud**.
- Los programas preventivos estarán orientados a fomentar aquellos **comportamientos alternativos a los consumos de drogas**, a través de la modificación de hábitos, actitudes, información y valores, así como de las condiciones del entorno que favorezcan dichos comportamientos de riesgo.
- Los programas preventivos se dirigirán preferentemente a sectores específicos de la sociedad, especialmente a la **población infantil, adolescente y otras de especial riesgo**, y contarán en su diseño, ejecución y evaluación con la participación de personas, entidades y asociaciones que puedan favorecer el cumplimiento de los objetivos del programa, y especialmente con los Organismos Públicos competentes en materia de menores.

2.3.- ASISTENCIA E INTEGRACIÓN.

2.3.1.- ASISTENCIA A DROGODEPENDIENTES.

Las **acciones asistenciales** que se desarrollen en la Comunidad de Madrid dirigidas hacia los sujetos afectados por drogodependencias y otros trastornos adictivos, tendrán por **finalidad:**

1.- Garantizar la **asistencia a las personas afectadas** por problemas de consumo y dependencia de drogas y otros trastornos adictivos **en condiciones de equidad con otras enfermedades**, asegurando en todo caso la **calidad y eficacia de los diferentes servicios y programas integrados en la red sanitaria única de utilización pública.**

2.- Potenciar los **programas de integración social** como objetivo del proceso asistencial, favoreciendo la conexión de los programas asistenciales con los primeros. Como mejor vía de integración social, se desarrollarán estrategias orientadas al **acceso y mantenimiento en el ámbito laboral** de la población drogodependiente.

3.- Garantizar el respecto a los **derechos de las personas drogodependientes** como usuarios de los distintos servicios.

4.- Adecuar los dispositivos asistenciales de la red pública a las necesidades asistenciales de las personas drogodependientes, y de aquellas que padezcan otros trastornos adictivos, garantizando el **acceso libre a dichos dispositivo**s, de acuerdo con la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y con la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid.

5.- **Mejorar los niveles de salud y la calidad de vida** de las personas drogodependendientes.

6.- Reducir la **problemática social y jurídico-penal** de la población drogodependiente.

7.- Impulsar la cultura social favorecedora de la **solidaridad y colaboración de la comunidad en la asistencia e integración social de las personas drogodependientes,** y que incluya un rechazo al consumo de drogas.

8.- Cooperar con las **organizaciones no gubernamentales y las asociaciones de auto-ayuda** de afectados y familiares, como colaboradores del proceso asistencial.

Los **servicios sanitarios** públicos de atención a drogodependientes de la Comunidad de Madrid adecuarán sus actuaciones a los siguientes **criterios:**

1.- La oferta terapéutica para la atención a las personas drogodependientes deberá ser **accesible y diversificada, profesionalizada y de carácter interdisciplinar**, incluyendo las diferentes tipologías de tratamiento de eficacia científica reconocida existentes, incluyéndose como un apartado más las diferentes líneas de intervención definidas como reducción de los riesgos y los daños, entre las cuales deben incluirse:

- De **prevención de enfermedades y de asesoramiento y apoyo psicológico** dirigidos a las personas afectadas y a las personas que conviven con ellas.
- De mantenimiento, mediante la **prescripción y dispensación de medicación sustitutiva** en la red asistencial.
- De **educación sanitaria**, que facilite a los afectados la adecuada utilización de los recursos sanitarios necesarios para evitar la transmisión de enfermedades.

2.- La asistencia a drogodependencias se prestará en el **ámbito comunitario**, aplicando con carácter preferente el criterio de **proximidad al domicilio del usuario y su entorno**, potenciándose los dispositivos y programas asistenciales en **régimen ambulatorio**.

3.- La atención al drogodependiente y sus familiares se realizará a través del **sistema sanitario público y del sistema de servicios sociales de la Comunidad de Madrid**, adecuando sus recursos en función de las necesidades de la población e incorporando, cuando sea necesario, los recursos privados, convenientemente acreditados, para completar y diversificar los programas terapéuticos.

4.- La atención sanitaria tendrá como objetivos principales, la **desintoxicación, la deshabituación, la disminución de riesgos, la reducción de daños y la mejora de las condiciones generales de salud** de las personas con drogodependencias, siendo la **integración social** del drogodependiente el objetivo final del proceso asistencial, para lo cual se coordinarán los diferentes recursos y dispositivos de la red.

5.- La **integración social** de las personas drogodependientes se apoyará en las redes generales y en su familia y entorno afectivo, adoptando, cuando sea necesario, medidas especiales destinadas a conseguir la igualdad de oportunidades.

6.- La **evaluación permanente de la calidad de los procesos y resultados** de los diferentes centros, servicios y modelos de atención.

La **Administración de la Comunidad de Madrid**, dentro del ámbito de sus competencias y en colaboración con las Administraciones Públicas correspondientes, así como las entidades e instituciones privadas, convenientemente acreditadas, promoverá las siguientes **actuaciones:**

1.- La atención a los drogodependientes desde las **redes generales de los sistemas sanitarios y de servicios sociales**, siempre desde un **enfoque multidisciplinar**, especialmente en el nivel primario.

2.- La **adecuación progresiva de la oferta asistencial en centros específicos** de atención a drogodependientes, fundamentalmente en cuanto al desarrollo de actividades, programas, plazas y en todas aquellas medidas que favorezcan la accesibilidad de los usuarios a los recursos y faciliten su atención.

3.- La **inspección y control periódico de los centros, servicios, establecimientos** y otros dispositivos de atención al drogodependiente, ya sean de carácter público o privado.

4.- La realización de programas encaminados a la **disminución de riesgos, reducción de daños y mejora de las condiciones sociales y sanitarias** del drogodependiente, incluyendo actividades de educación sanitaria, asesoramiento y apoyo psicológico a personas usuarias de drogas portadoras de enfermedades transmisibles y a sus familiares.

5.- El desarrollo de programas específicos dirigidos a la **población drogodependiente de alta cronicidad y máximo riesgo sanitario**. Estos programas incluirán la accesibilidad a tratamientos con sustitutivos opiáceos u otros fármacos de eficacia clínica demostrada, el control sanitario y la atención social y personalizada.

6.- La potenciación de pr**ogramas de integración social de personas drogodependientes y de asesoramiento a sus familiares**, así como los de **formación ocupacional y profesional** del drogodependiente, con objeto de conseguir su progresiva integración social y laboral.

7.- La **sensibilización de la sociedad en general**, con el fin de promover la participación activa y solidaria de la comunidad en el proceso de asistencia e integración social del drogodependiente y de modificar las actitudes negativas hacia el mismo.

8.- La potenciación de programas y recursos dirigidos específicamente a **mujeres drogodependientes con cargas familiares no compartidas y con otros factores añadidos de riesgo.**

9.- La **equiparación del drogodependiente a otros enfermos**, y la consideración de la drogodependencia, a efectos asistenciales, como una enfermedad.

La Comunidad de Madrid en el **ámbito judicial y penitenciario**:

1.- Promoverá la realización de programas de educación sanitaria y atención, encaminados fundamentalmente a la **reducción de riesgos y daños** y a la mejora de las condiciones generales de salud del drogodependiente.

En este mismo sentido se incorporarán programas dirigidos a aquellos reclusos portadores del virus de inmunodeficiencia adquirida humana (VIH), tuberculosis y otras patologías, destinados fundamentalmente a evitar la transmisión de estos procesos.

2.- Favorecerá la **asistencia al penado en el medio penitenciario** con el fin de que éste realice un proceso de tratamiento en el medio en que se encuentra y facilitar así su futura integración social.

En este sentido promoverá la adopción de convenios de colaboración con otras Administraciones. En todos estos casos, la competencia en la adopción de estrategias terapéuticas residirá en los técnicos del organismo competente en materia de asistencia sanitaria al drogodependiente de la Comunidad de Madrid.

3.- Propiciará, a través de centros y servicios públicos o privados acreditados, la posibilidad de dar curso a las demandas de **medidas alternativas al cumplimiento de la pena** u otras medidas exigidas por la Administración de Justicia e Instituciones Penitenciarias de atención al drogodependiente en los recursos de la red pública.

4.- Mantendrá canales de información permanentes con la Administración Penitenciaria, para de esta forma favorecer el acceso del interno, una vez haya cumplido su pena de privación de libertad, a los **recursos asistenciales normalizados en el medio comunitario.**

5.- Establecerá programas de colaboración para atender de forma eficaz los **problemas de naturaleza jurídico-penales de la población drogodependiente**. Este apartado incluirá la función de asesoramiento y formación a las diferentes Instituciones u Organizaciones implicadas en el campo de las drogodependencias en los ámbitos judicial y penitenciario.

En el **ámbito laboral:**

1.- La Comunidad de Madrid impulsará la realización de programas de **prevención y asistencia de trabajadores con problemas de consumo de drogas, incluido el alcohol y el tabaco**, así como con otros tipos de trastornos adictivos. En el diseño, ejecución y evaluación de estos programas podrán participar los sindicatos, organizaciones empresariales y servicios de prevención, así como los Comités de Seguridad y Salud en las empresas e instituciones.

2.- La Comunidad de Madrid potenciará los acuerdos entre organizaciones empresariales y sindicatos encaminados a la **reserva de puesto de trabajo de los trabajadores drogodependientes durante su proceso de recuperación.** El Gobierno Regional facilitará en el marco de dichos acuerdos la atención a los trabajadores afectados.

3.- La Comunidad Autónoma en sus centros, establecimientos y servicios, **reservará el puesto de trabajo de la persona drogodependiente durante el proceso de tratamiento,** en las condiciones y con las limitaciones que contempla la normativa aplicable. Los Comités de Seguridad y Salud de las distintas dependencias de la Administración Regional velarán por la aplicación de lo dispuesto en la presente Ley a sus trabajadores.

4.- El Gobierno Regional promoverá la creación de un clima favorecedor para que las drogodependencias, tal y como están definidas en la presente Ley, o las patologías derivadas del consumo de drogas, **no sean un instrumento de discriminación en el ámbito laboral.** Asimismo, se facilitará desde dicho medio el acceso de los drogodependientes a los servicios especializados en atención a las drogodependencias.

El **Sistema de Asistencia al drogodependiente** se configura como una **red de atención pública diversificada,** que integra de forma coordinada **centros y servicios generales y específicos, complementados con recursos privados debidamente acreditados.**

- Los centros y servicios sociosanitarios de atención a drogodependientes se sujetarán, en todo caso, a las **medidas de inspección, control e información estadística, sociosanitaria** y de cualquier otro tipo que establezca la legislación vigente.

El Sistema de Asistencia al Drogodependiente se estructura en dos niveles de intervención:

a. Un **primer nivel** a cargo, fundamentalmente, de los centros, dispositivos y programas de atención básica cuyas funciones esenciales son la información, orientación, diagnóstico, detección precoz, reducción del daño y otras análogas.
b. Un **segundo nivel**, configurado por **unidades específicas**.

La **Dirección General de Salud Pública** (antes Agencia Antidroga) establecerá los mecanismos de coordinación y líneas de actuación de los centros, servicios, dispositivos y recursos de la red pública, garantizando una actuación integral en el territorio.

2.3.2.- INTEGRACIÓN DE LOS DROGODEPENDIENTES.

Los **criterios generales de integración** de los drogodependientes son:

1.- La cobertura de las situaciones de necesidad social y el desarrollo de acciones dirigidas a la integración social de las personas drogodependientes corresponde, mediante la adecuada coordinación, a los Organismos competentes en materia de drogodependencias y de servicios sociales de la Comunidad de Madrid.

2.- La **integración social del drogodependiente** forma parte, como un elemento más, de un plan global que comprende no sólo aspectos biológicos, psicológicos y sociales del fenómeno de las drogodependencias, sino también la intervención sobre el individuo, su entorno y la comunidad.

La citada integración debe aceptarse como un **proceso flexible**, en el que caben objetivos mínimos, intermedios y definitivos, por lo que deberá promover y afianzar actitudes y hábitos de autonomía personal, autoestima y asunción de responsabilidades.

3.- **La igualdad en el acceso a los recursos, actividades y prestaciones del sistema**, abarca a las personas drogodependientes como a cualquier ciudadano, con sus derechos y obligaciones, insertándolas en el conjunto de las acciones normalizadas de todos los servicios públicos.

4.- Los poderes públicos potenciarán aquellas actuaciones encaminadas a favorecer la integración social del drogodependiente, mediante la **utilización conjunta y coordinada de los diferentes programas de la red de servicios sociosanitarios y de servicios sociales**.

5.- La Administración Autonómica desarrollará programas orientados a la **promoción del movimiento asociativo y a la integración social y familiar, y se fomentará el voluntariado** u otras formas de apoyo y ayuda al drogodependiente que actúen coordinadamente con la red de servicios sociosanitarios.

6.- Las Administraciones Públicas **evaluarán los recursos destinados a la integración** y procurarán su adecuación a las necesidades reales de la población drogodependiente.

La **integración social de las personas drogodependientes** se realizará mediante una **intervención individual y comunitaria**, persiguiendo como fin último la integración y normalización del individuo en la sociedad, apoyándose en sus recursos personales y sociales.

La Administración Autonómica desarrollará programas destinados a facilitar al drogodependiente la **adquisición y el desarrollo de las estrategias y los recursos personales y sociales** que sean necesarios para su integración.

- En el **ámbito familiar**, se fomentarán estrategias dirigidas específicamente al apoyo y asistencia del entorno familiar del drogodependiente.
- En el **ámbito laboral**, se potenciarán aquellas actuaciones que incidan sobre el acceso al mismo de las personas drogodependientes, y en especial a través de acciones como planes de empleo, desarrollo de los aspectos personales para la ocupación, información profesional y técnicas de búsqueda activa del empleo. Asimismo, se establecerán planes de formación que capaciten a los drogodependientes y les permitan una más factible incorporación laboral.
- En el **ámbito de la juventud**, se impulsarán intervenciones que fomenten la formación de grupos que, además de cumplir una importante función de prevención, se conviertan en instrumentos de integración de la juventud marginada en nuestra sociedad. A estos efectos, se aprovecharán especialmente los correspondientes programas generales educativos de capacitación profesional, los de empleo, los de vivienda y los de la red de servicios sociosanitarios.

2.3.3.- CENTROS DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN DEL DROGODEPENDIENTE.

Los centros de asistencia e integración a los drogodependientes serán aquellos **tanto públicos como privados**, que realicen actuaciones específicas sobre la condición de drogodependiente y con el objetivo último de **proporcionar un programa terapéutico dirigido a eliminar su adicción, normalizar su conducta y conseguir su integración social**.

Se incluyen en el ámbito de esta Ley los centros o servicios de carácter público o privado que actúan específicamente en la asistencia o integración social de los drogodependientes, y en especial los de las organizaciones no gubernamentales que actúan en el sector de las drogodependencias.

Los **requisitos mínimos** de los centros de asistencia e integración de los drogodependientes.

a. Contar con el **personal suficiente** con la titulación y con las **instalaciones y equipamientos**, condiciones de capacidad e infraestructuras que reglamentariamente se determinen.
b. El **régimen de funcionamiento interno** y procedimientos de actuación de estos centros serán regulados en el desarrollo reglamentario de la presente Ley.

La Comunidad de Madrid establecerá reglamentariamente las normas que deberán cumplir para poder ser acreditados y concertados por la propia Administración.

2.4.- COMPETENCIAS DE LAS CORPORACIONES LOCALES.

Ayuntamientos de la CM	a.- La determinación de los criterios que regulen la localización, distancia y requisitos que deberán reunir los establecimientos donde se suministre, venda, dispense o consuman bebidas alcohólicas y tabaco, así como la vigilancia y control de los mismos. b.- El otorgamiento de la licencia de apertura y, en su caso, de funcionamiento, a los establecimientos mencionados en el apartado anterior. c.- Velar, en el marco de sus competencias, por el cumplimiento de las diferentes medidas de control, especialmente en las dependencias municipales. d.- Adoptar las medidas cautelares dirigidas a asegurar el cumplimiento de lo establecido en esta Ley.
Ayuntamientos de más de 20.000 hab.	a.- La aprobación y ejecución del Plan Municipal sobre Drogodependencias y otros trastornos adictivos, elaborado en coordinación y de conformidad con los criterios establecidos por el Organismo regional competente en materia de drogodependencias, y lo regulado en la presente Ley. b.- La ejecución de los programas de prevención que se desarrollen exclusivamente en el ámbito de su municipio. c.- El fomento de la participación social y el apoyo a las instituciones sin ánimo de lucro que en el municipio desarrollen las actuaciones previstas en el Plan Municipal sobre Drogodependencias.

3.- PLAN DE ADICCIONES DE LA CIUDAD DE MADRID, 2.022-2.026.

La experiencia del Ayuntamiento de Madrid en la atención a las adicciones se inicia con el primer Plan Municipal contra las Drogas aprobado el 8 de mayo de 1988. Entonces, se promovió un modelo de abordaje de las adicciones flexible y adaptado a los distintos perfiles de las personas con adicciones o en riesgo de desarrollarlas. A través de él se ha ido estructurando una red con una serie de recursos utilizados a lo largo del proceso de atención integral.

Esta red dispone de Centros de Atención a las Adicciones (CAD) que desarrollan una atención interdisciplinar (biopsicosocial) y una serie de servicios y recursos de apoyo al tratamiento y a la reinserción (pisos, plazas en comunidad terapéutica, centro de patología dual). También se constituyen una serie de recursos para la detección y acceso de las personas más vulnerables, siempre desde una perspectiva de trabajo comunitario, coordinado con los territorios y en los entornos naturales.

Las líneas estratégicas en las que se enmarca el Plan se articulan entorno a la prevención en el ámbito educativo y comunitario, la atención integral de adolescentes y jóvenes y de personas adultas. Todas las acciones tienen perspectiva de género para adaptar las acciones a las necesidades específicas de las mujeres y para prevenir y detectar la violencia de género. En los últimos años se ha potenciado la intervención en trastorno por juego de azar y uso abusivo de la tecnología.

El 17 de marzo de 2011, por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, se aprobó el **Plan de Adicciones de la Ciudad de Madrid 2011-2016**, que puso el enfoque de la intervención en función de las características de la persona y no de la sustancia. Además, el modelo de abordaje de las adicciones mostró una especial atención a aquellos grupos sociales más vulnerables.

El **Plan de Adicciones 2017-2021** fue aprobado por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid el 19 de octubre año 2017. Este Plan ha sido evaluado anualmente, dando cuenta en el Foro Técnico de las Adicciones, órgano colegiado en el que participan diversas áreas y direcciones generales del Ayuntamiento, así como otras instituciones y entidades sociales que desarrollan su actividad en el ámbito de las adicciones en la Ciudad de Madrid. En su seno han desarrollado cinco comisiones, que han trabajado sobre los temas más relevantes y necesitados de coordinación: Intervención familiar, adolescentes y jóvenes, drogodependientes sin hogar y otros colectivos en riesgo de exclusión, integración social y empleo y perspectiva de género en adicciones.

En 2021, el Ministerio de Sanidad otorgó a la Subdirección General de Adicciones del Organismo Autónomo Madrid Salud la medalla de oro de la Orden de Mérito del Plan Nacional sobre Drogas, por su labor de prevención y asistencia a las personas con adicciones durante la pandemia.

3.1.- MARCO NORMATIVO.

El **Plan de Adicciones 2022/26** de la Ciudad de Madrid se enmarca en las políticas y estrategias en materia de lucha contra la droga desarrolladas por la UE, España, Plan Nacional sobre Drogas, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid.

POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE LA UNIÓN EUROPEA.

. Estrategia 2.021/2.025 (24 de marzo de 2.021).

La finalidad es «**proteger y mejorar el bienestar de la sociedad y de las personas, salvaguardar y promover la salud pública»**. Así, defiende un planteamiento empírico, contrastado, integrado, equilibrado y multidisciplinar del fenómeno de las drogas a escala nacional, internacional y de la UE. Además, incorpora la **perspectiva de igualdad de género y de equidad sanitaria**.

La Estrategia se fundamenta en los principios del Derecho de la Unión y respeta los valores fundacionales de la UE: el respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, la solidaridad, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Asimismo, se basa en el Derecho internacional, las Convenciones pertinentes de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos.

La Estrategia propone **tres ámbitos de actuación**:

• Reducción de la oferta de droga: mejora de la seguridad.

• Reducción de la demanda de droga: servicios de prevención, tratamiento y asistencia.

• Abordar los daños relacionados con las drogas.

POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS NACIONALES.

. Constitución Española, art. 43. Derecho a la protección de la salud.

. Estrategia sobre Adicciones, 2.017-2.024.

Los principios rectores en los que se fundamenta son: la equidad, la perspectiva de género, la transparencia, la evidencia científica, la participación, la intersectorialidad y la interdisciplinariedad, la calidad, la eficiencia y la sostenibilidad.

Propone dos metas fundamentales para este periodo:

a) «Alcanzar una sociedad más saludable e informada mediante la reducción de la demanda de drogas y de la prevalencia de las adicciones en general».

b) «Tener una sociedad más segura a través de la reducción de la oferta de drogas y del control de aquellas actividades que puedan llevar a situaciones de adicción»

. L.O. 4/2.015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.

Dispone que «las multas que se impongan a los menores de edad por la comisión de infracciones en materia de consumo o tenencia ilícitos de drogas… podrán suspenderse siempre que, a solicitud de los infractores y sus representantes legales, aquéllos accedan a someterse a tratamiento o rehabilitación, si lo precisan, o a actividades de reeducación».

POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS COMUNIDAD DE MADRID.

. Ley 5/2.002, de 27 de junio sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos y Ley 12/2.001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid.

POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS AYUNTAMIENTO DE MADRID.

. Creación de la Comisión Antidroga, 31 de julio de 1.987.

. Estatutos del Organismo Autónomo Madrid-Salud, 2.004.

3.2.- PRINCIPIOS Y CRITERIOS ORIENTADORES DEL PLAN.

Los **principios y criterios orientadores del Plan de Adicciones de la Ciudad de Madrid**, son el soporte de todas las actuaciones que en él se desarrollan. Permiten la adaptación de las acciones a la evolución de las adicciones y mantienen, en todo momento, una responsabilidad ética en el servicio a la ciudadanía.

COMPROMISO ÉTICO.

Las acciones desarrolladas en el presente Plan de Adicciones tendrán en cuenta los principios éticos de **humanidad, autonomía, justicia e inocuidad, así como el respeto a los derechos humanos**. El Plan de Adicciones de la Ciudad de Madrid está alineado con la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

ENFOQUE INTEGRAL.

Entender las adicciones como un **fenómeno complejo, multicausal y multifactorial**. Las intervenciones se aplicarán desde un **modelo bio-psico-social**, tanto para la prevención como para la asistencia y reinserción de las adicciones.

UNIVERSALIDAD Y EQUIDAD.

Dar acceso a toda la población, en **igualdad de condiciones y sin discriminación**, a las prestaciones preventivas, asistenciales y de integración social, con **carácter público** según su necesidad, prestando una especial atención a aquellos grupos sociales más vulnerables.

INTERSECTORIALIDAD.

Promover la **coordinación y cooperación** entre las diversas redes públicas, instituciones y organizaciones sociales, para articular respuestas de adaptadas, de calidad y con evidencia.

INTEGRACIÓN Y NORMALIZACIÓN.

Los procesos que se realicen tendrán como objetivo último el de conseguir el **mayor grado posible de integración socia**l. Priorizando la **utilización de los recursos normalizados** existentes y potenciando el mantenimiento o la recuperación de los vínculos familiares y sociales.

ADAPTABILIDAD E INNOVACIÓN.

Monitorizar los cambios sociales y los que se produzcan en el ámbito de las adicciones, con el fin de conocer las **necesidades emergentes** y poder articular respuestas adaptadas a las mismas.

CALIDAD Y EVIDENCIA CIENTÍFICA.

Las acciones del Instituto de Adicciones están orientadas hacia la **mejora continua, la búsqueda de la satisfacción de los usuarios/as, la eficiencia y la efectividad**, a través de procesos de formación, investigación y evaluación continua. Las acciones desarrolladas por este Plan se basarán en la **evidencia científica.**

PERSPECTIVA DE GÉNERO.

Los programas, servicios y acciones que se realicen estarán adaptados a las **características y necesidades diferenciadas de hombres y mujeres** derivadas de su rol de género.

En línea con la Estrategia 2017-2024 del Plan Nacional contra las Drogas, la perspectiva de género implica tres líneas de trabajo:

• Incorporar los condicionantes de género y sus consecuencias dentro de los análisis que explican las adicciones.

• Promover los tratamientos centrados en las mujeres y sus consumos.

• Fomentar la atención integral y coordinación de recursos a las mujeres que sufren violencia de género.

Además, todos los indicadores referidos a personas estarán desagregados por sexo, incluyéndose también indicadores de género para identificar brechas y poder reducirlas.

PERSPECTIVA DE DIVERSIDAD IDENTITARIA.

Se desarrollarán las medidas necesarias para facilitar el acceso y la atención a las **personas con identidades diversas** (orientación sexual, diversidad funcional, etnia, cultura, idioma, etc.), de forma que se pueda dar una respuesta ajustada a sus necesidades.

REDUCCIÓN DEL ESTIGMA.

El estigma asociado a las adicciones supone una barrera para la recuperación de las personas que las sufren. Para ello desde el Instituto de Adicciones se fomentará, de forma proactiva, **un cambio de percepción de este estigma** mediante la información y sensibilización tanto a la población general como a otros profesionales sociosanitarios. Se impulsará el uso de un lenguaje adecuado y no ofensivo para evitar la discriminación.

El Plan de Adicciones de la Ciudad de Madrid tiene como **misión**, evitar o reducir los problemas de adicción de la población madrileña, así como los daños y consecuencias que pueden afectar a la persona adicta, a su entorno familiar y social próximo y a la comunidad en su conjunto.

3.3.- LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y OBJETIVOS.

La planificación de las acciones a desarrollar en el presente Plan en orden a la consecución de sus objetivos se orientará según una serie de directrices o líneas estratégicas que son las siguientes:

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. Prevención frente a los riesgos relacionados con las adicciones.

• Sensibilizar, informar y formar a la población general y de forma específica a adolescentes y jóvenes sobre prevención de adicciones, así como incrementar la visibilidad y accesibilidad de los recursos del Instituto de Adicciones.

• Promover acciones de prevención selectiva dirigidas a adolescentes y jóvenes, familiares y otras personas adultas de referencia para aumentar la percepción de riesgo y retrasar la edad de inicio en la experimentación con sustancias o con diversos objetos de adicción.

• Potenciar la detección precoz y captación proactiva de adolescentes y jóvenes en riesgo de adicción.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2. Atención integral a adolescentes y jóvenes, tanto los que presentan una situación de riesgo como quienes cumplen criterios de adicción.

• Ofrecer a adolescentes y jóvenes atención integral, tanto los que presentan una situación de riesgo como quienes cumplen criterios de adicción a través de la red de Centros de Atención a las Adicciones (CAD).

• Ofrecer recursos específicos para la atención integral de adolescentes y jóvenes.

• Ofrecer a las familias de adolescentes y jóvenes intervenciones preventivas y/o terapéuticas

LÍNEA ESTRATÉGICA 3. Reducción de los riesgos y daños asociados a las adicciones.

• Garantizar la existencia de recursos y servicios de detección, captación y de reducción del daño para personas en situación de consumo activo.

• Promover medidas de mediación comunitaria.

LÍNEA ESTRATÉGICA 4. Tratamiento integral de las personas con adicciones.

• Ofrecer tratamiento integral a las personas con adicciones a través de la red de Centros de Atención a las Adicciones (CAD).

• Facilitar la integración sociorrelacional y laboral de pacientes mediante actividades dirigidas al desarrollo de sus habilidades sociales, culturales, formativas y laborales.

• Garantizar la existencia de una red de dispositivos hospitalarios y residenciales terapéuticos de apoyo al tratamiento integral.

• Potenciar las actuaciones específicas de tratamiento integral para mujeres.

• Ofrecer intervención a las personas sin hogar con adicciones en la red del Instituto de Adicciones y en la red de atención a las personas sin hogar.

• Ofrecer a las familias de las personas con adicciones la atención, el apoyo y la orientación necesarios.

LÍNEA ESTRATÉGICA 5. Atención y prevención de la adicción al juego.
• Prevenir las conductas de riesgo y adicción al juego y a los videojuegos mediante la sensibilización y otras actividades preventivas. • Tratamiento integral y especializada a las personas afectadas y sus familias • Actuaciones específicas sobre zonas más vulnerables.
LÍNEA ESTRATÉGICA 6. Coordinación y trabajo en red.
• Desarrollar y mejorar las estrategias de coordinación con los grupos de interés • Desarrollar las funciones de coordinación del Foro Técnico de Adicciones
LÍNEA ESTRATÉGICA 7. Calidad y mejora continua.
• Garantizar y potenciar la calidad en todos los niveles de la organización, actualizando y evaluando los procesos y los servicios prestados mediante el establecimiento de indicadores de gestión y estándares de calidad. • Gestionar los servicios con eficacia y eficiencia, de forma participativa y transparente, mejorando de forma continua y rindiendo cuentas a la ciudadanía. • Potenciar el desarrollo del conocimiento: formación, investigación y docencia.

3.4.- PREVENCIÓN FRENTE A LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LAS ADICCIONES.

El Instituto de Adicciones se compromete a realizar una acción preventiva con un enfoque dirigido a adolescentes y jóvenes de la Ciudad de Madrid, sus familiares y otras personas adultas de referencia (**prevención selectiva e indicada**), sin dejar de cumplir su responsabilidad con el conjunto de la ciudadanía, a través de las acciones de sensibilización e información (**prevención universal**).

Sensibilizar, informar y formar a la población general y de forma específica a adolescentes y jóvenes sobre prevención de adicciones, así como incrementar la visibilidad y accesibilidad de los recursos del Instituto de Adicciones.	
Establecer y desarrollar espacios digitales y canales de información con la ciudadanía.	. Mantenimiento y actualización del espacio WEB del Instituto de Adicciones de Madrid Salud . Mantenimiento y mejora del Chat online y la atención telefónica que genera la web del Instituto de Adicciones. . Mantenimiento y actualización del blog del servicio PAD para familias, profesionales y ciudadanía. . Mantenimiento y actualización de perfiles en las diferentes redes sociales. . Mantenimiento y mejora de la formación online. . Difusión de información dirigida a la población general sobre adicciones y los recursos de la red del Ayuntamiento. . Utilización de lenguaje no sexista e imágenes no estereotipadas que fomenten la diversidad en materiales preventivos

Sensibilizar e informar a la plantilla del Ayuntamiento sobre prevención en adicciones.	. Realización de comunicaciones informando sobre los recursos de acceso a la red de tratamiento en los canales internos del Ayuntamiento (AYRE, TEAMS, CORREO) . Realización de comunicaciones con información de carácter preventivo a través de los canales internos del Ayuntamiento (AYRE, TEAMS, CORREO)
Promover acciones de prevención selectiva dirigidas a adolescentes y jóvenes, familiares y otras personas adultas de referencia para aumentar la percepción de riesgo y retrasar la edad de inicio en la experimentación con sustancias o con diversos objetos de adicción.	
Realizar prevención selectiva en ámbito educativo.	. Realización de sesiones grupales dirigidas a adolescentes y jóvenes en centros educativos . Realización de sesiones grupales para familiares en centros educativos . Realización de sesiones grupales dirigidas a otras personas adultas de referencia de la comunidad educativa y de los recursos comunitarios . Coordinación y asesoramiento a la comunidad educativa sobre situaciones de adolescentes y jóvenes en riesgo en relación con adicciones.
Incorporar la perspectiva de género en la prevención de adicciones.	. Realización de formaciones para las y los profesionales y el voluntariado en perspectiva de género en prevención de las adicciones. . Intervención preventiva atendiendo a los condicionantes de género y sus consecuencias en las adicciones . Acciones preventivas específicas para mujeres.
Realizar prevención en ámbito comunitario	. Presentación de los servicios, programas y actuaciones preventivas a entidades y recursos de los 21 distritos. . Coordinación y asesoramiento al tejido distrital sobre situaciones de adolescentes y jóvenes en riesgo en relación con adicciones. . Acciones formativas dirigidas a mediadores/as . Acciones preventivas desarrolladas en los distritos dirigidas a adolescentes y jóvenes
Realizar programas preventivos en proximidad específicos	. Programa de promoción de la salud y prevención de las adicciones «QuiereT Mucho» Vallecas . Programa de promoción de la salud y prevención de las adicciones a través del deporte «Sembrando Salud» en Puente de Vallecas . Centro Juvenil de Prevención a través del Ocio: Espacio Juvenil San Blas . Centro de Prevención en Proximidad: «Embajadores Joven» . Programa de inclusión para personas en riesgo o con adicciones a través de la actividad físicodeportiva . Programa de Prevención en Proximidad en Villaverde . Impulsar nuevos programas de preventivos en proximidad
Realizar prevención ambiental y programas de reducción de riesgos	. Programa de Reducción de riesgos asociados al ocio juvenil «Acción Botellón» . Impulso de programas preventivos en entornos de ocio.

Potenciar la detección precoz y captación proactiva de adolescentes y jóvenes en riesgo de adicción.	
Identificar, contactar y motivar, en su entorno, a adolescentes y jóvenes en situación de riesgo o con alguna dimensión de la conducta adictiva	. Realizar entrevistas previas de asesoramiento a adolescentes y jóvenes . Realizar asesoramiento a personas adultas de referencia (profesorado, profesionales, etc.)

3.5.- ATENCIÓN INTEGRAL A ADOLESCENTES Y JÓVENES.

El Instituto de Adicciones se compromete a desarrollar un **programa de atención integral a adolescentes y jóvenes con adicciones o en riesgo de desarrollarlas con características, procedimientos y recursos adaptados** a esta población y diferenciados de los dirigidos a las personas adultas. Esta línea estratégica incluye la atención a las familias y la red de recursos de apoyo para abordar las diferentes situaciones relacionadas con la adicción de adolescentes y jóvenes.

Ofrecer a adolescentes y jóvenes atención integral, tanto los que presentan una situación de riesgo como quienes cumplen criterios de adicción a través de la red de Centros de Atención a las Adicciones (CAD).	
Adaptar el Plan Personalizado de Intervención al perfil de situación de adolescentes y jóvenes	. Realización de entrevista de valoración para determinar el perfil de situación. . Revisión y actualización del plan de tratamiento jóvenes y adolescentes . Evaluación de la herramienta de valoración del perfil
Ofrecer a adolescentes y jóvenes con riesgo de adicción una intervención preventiva adaptada a sus necesidades	. Evaluación de las intervenciones preventivas . Mejora en la agilidad, eficiencia y eficacia en la atención . Actualización de la intervención preventiva grupal. . Impulso de la coordinación con recursos preventivos del entorno . Mejora de las intervenciones con perspectiva de género . Potenciación de acciones para aumentar la detección y demanda de las mujeres
Ofrecer a adolescentes y jóvenes con criterios de adicción una intervención terapéutica acorde a sus necesidades.	. Actualización de la evaluación de la intervención terapéutica individual y grupal . Evaluación de las intervenciones terapéuticas . Mejora en la agilidad, eficiencia y eficacia en la atención . Mejora de las intervenciones con perspectiva de género . Impulso de la atención de mujeres adolescentes . Impulso de la integración de adolescentes y jóvenes en situación de exclusión sociorresidencial . Coordinación con Servicios Sociales para los adolescentes y jóvenes en riesgo de exclusión social . Coordinación con la red de salud mental para adolescentes y jóvenes con patología dual grave

Favorecer la integración social de las personas adolescentes y jóvenes atendidas con criterios de normalización y adaptado a las necesidades sociales propias de cada persona	. Realización de itinerario formativolaboral para favorecer la inserción . Coordinación con la Agencia para el Empleo (Garantía Juvenil) . Realización de grupos de ocio saludable . Talleres prelaborales específicos para jóvenes
Ofrecer recursos específicos para la atención integral de adolescentes y jóvenes.	
Ofrecer a adolescentes y jóvenes con adicciones recursos de apoyo al tratamiento	. Puesta en marcha, evaluación y seguimiento de recursos específicos para adolescentes y jóvenes . Adaptación de los recursos no específicos para la atención a adolescentes y jóvenes
Ofrecer a las familias de adolescentes y jóvenes intervenciones preventivas y/o terapéuticas.	
Ofrecer a las familias de adolescentes y jóvenes en riesgo de desarrollar una adicción intervenciones preventivas	. Mejora en la agilidad, eficiencia y eficacia en la atención . Evaluación de la intervención familiar . Intervenciones individuales del Servicio de orientación familiar . Intervenciones grupales del servicio de orientación familiar
Ofrecer a las familias de adolescentes y jóvenes con una adicción intervenciones terapéuticas	Actualización del protocolo de Intervención terapéutica familiar . Intervenciones terapéuticas grupales . Programa de apoyo a la familia de FERMAD

3.6.- REDUCCIÓN DE LOS RIESGOS Y DAÑOS ASOCIADOS A LAS ADICCIONES.

El Instituto de Adicciones se compromete a ofertar a las personas adultas con adicciones, la atención integral y los recursos necesarios para abordar la reducción de daños y riesgos asociados a la adicción, procurando la **mejora de su calidad de vida, así como la del entorno comunitario**.

La reducción de daños se refiere al **conjunto de políticas, programas e intervenciones orientadas a minimizar el impacto negativo sobre la salud y las consecuencias sociales y legales asociadas al consumo de sustancias y a las políticas y leyes sobre drogas.**

Se basa en fundamentos de salud pública y de justicia y derechos humanos, adoptando un enfoque realista que permite abordar la problemática de las drogas sin prejuicios, centrándose en los cambios positivos y en el trabajo con las personas, evitando su discriminación y estigmatización en relación con su consumo de sustancias. El objetivo principal no es eliminar el consumo sino favorecer un uso de sustancias que ocasione los mínimos daños posibles tanto a la persona como a su entorno y a la sociedad.

El enfoque de la reducción de daños reconoce que muchas personas con problemas de adicción no quieren o no pueden conseguir o mantener la abstinencia, pero deben proporcionarse opciones de tratamiento ajustadas a sus necesidades, que permitan tomar decisiones informadas, orientadas a la salud y a la mejora de su calidad de vida. El objetivo de abstinencia no se rechaza, aunque no se plantea como un objetivo a conseguir a corto plazo.

Garantizar la existencia de recursos y servicios de detección, captación y de reducción del daño para personas en situación de consumo activo.	
Potenciar la implantación y desarrollo de servicios de atención en proximidad en los distritos	. Puesta en marcha, evaluación y seguimiento de Servicios o programas de atención en proximidad en distritos
Potenciar las salas de reducción del daño para personas con problemas con el alcohol en los centros de la red social de atención a personas sin hogar	. Favorecer la apertura, asesoramiento y apoyo de nuevas salas de reducción del daño en los centros que así lo demanden . Evaluación semestral del programa de las salas existentes
Promover la formación de agentes de salud en los recursos y servicios de detección, captación y de reducción del daño para personas en situación de consumo activo	. Acciones de formación para agentes de salud. . Acciones de formación en violencia de género.
Potenciar la red de recursos de reducción del daño: Centro de Atención Básica Sociosanitaria Unidad Móvil de Reducción del Daño «Madroño» Centro de Atención Psicosocial Cañada Real Programa de intervención y mediación intercultural dirigido a personas con adicciones de origen extranjero «ISTMO»	. Acciones para aumentar la accesibilidad y agilidad en la atención en estos recursos. . Acciones para aumentar la derivación de pacientes a la red de tratamiento . Puesta en marcha de programas o recursos de consumo supervisado . Atención prioritaria a las mujeres con adicciones especialmente vulnerables. . Acciones para evitar transmisión de enfermedades como VIH, hepatitis B, hepatitis C, otras ITS
Promover la sensibilización y formación en aspectos relacionados con la reducción del daño.	. Elaboración un protocolo de intervención de reducción de daños . Acciones de formación y difusión en reducción de daños . Acciones para la participación de las personas que mantienen consumo de sustancias en la elaboración de materiales y recursos formativos.
Promover medidas de mediación comunitaria.	
Disminuir la conflictividad en las inmediaciones de los dispositivos de atención	. Acciones de coordinación del programa de mediación comunitaria con los servicios de reducción del daño . Elaboración de un Procedimiento conjunto con Samur Social (Equipos de calle) para actuar en zonas emergentes con mayor impacto social y ambiental relacionado con las adicciones (mesa de trabajo permanente). . Coordinación con Juntas de Distrito, otras áreas del ayuntamiento (limpieza, seguridad, servicios sociales, igualdad…) y con otras administraciones (Policía Nacional, …) . Acciones de sensibilización e información con agentes sociales, vecinos y comerciantes

3.7.- TRATAMIENTO INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON ADICCIONES.

El Instituto de Adicciones se compromete a ofrecer intervención terapéutica a las personas con adicciones desde una **perspectiva integral y biopsicosocial** cuyo objetivo último es el logro del **mayor grado posible de salud, bienestar e integración social y laboral.**

Ofrecer tratamiento integral a las personas con adicciones a través de la red de Centros de Atención a las Adicciones (CAD).

Mejorar la accesibilidad a los CAD	. Mejora del posicionamiento de los CAD en los buscadores de internet. . Puesta en marcha en los siete CAD del sistema de cita previa . Puesta en marcha de una Centralita través de una «Call Queue» en los siete CAD
Reducir el estigma asociado a los tratamientos de adicciones	. Información, sensibilización y formación en adicciones a otras redes de atención sociosanitaria y población general . Difusión de centros y servicios del Instituto de Adicciones
Ofrecer una intervención integral, basada en la evidencia y de calidad a las personas con adicciones en tratamiento en los CAD.	. Cumplimiento de los compromisos de la Carta de Servicios. . Revisión de Plan Personalizado de Intervención (PPI) . Elaboración del Plan de Tratamiento y realización de un procedimiento de buenas prácticas . Intervención individual y grupal en función de las características y necesidades del paciente y su momento en el proceso de tratamiento . Revisión y actualización de los protocolos clínicos y herramientas de intervención y seguimiento de su cumplimiento. . Elaboración de nuevos protocolos y/o procedimientos
Ofertar tratamientos farmacológicos para el trastorno por consumo de opioides, adaptados a la situación de cada persona.	. Tratamientos diversificados para la adicción a opioides: metadona (en solución o comprimidos), bruprenorfina/naloxona y buprenorfina de liberación prolongada IM . Dispensación en oficinas de farmacia
Ofrecer Tratamiento integral de la patología dual	. Refuerzo de intervenciones especializadas integrales con médicos/as especialistas en psiquiatría en la red del Instituto de Adicciones. . Formación continuada en patología dual de profesionales. . Oferta de recursos especializados en el tratamiento integral de la patología dual . Coordinación con la Red de Salud Mental de la Comunidad de Madrid para la elaboración de programas, protocolos y procedimientos conjuntos
Impulsar la prevención, detección precoz e intervención frente a las diferentes patologías infecciosas asociadas al consumo.	. Actualización en la Formación de profesionales. . Refuerzo de los instrumentos y técnicas de screening y detección precoz de infección por VIH, TBC y otras ITS . Cribado de hepatitis C periódico de personas vulnerables en los siete Centros de Atención a las Adicciones para conocer la prevalencia de VHC activa en las personas usuarias y así proceder a la derivación directa a atención especializada de los hospitales de referencia

	. Promover circuitos coordinados de actuación con atención primaria y especializada para eliminación VHC . Participación del Instituto de Adicciones en el Comité Local del Fast Track HIV de la ciudad de Madrid y en el del movimiento #hepcityfree, ciudades libres de hepatitis c, de la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (AEHVE).
Adaptar las intervenciones terapéuticas para personas mayores, crónicos y/o con deterioro cognitivo	. Formación continua de profesionales. . Realización de guía para intervención con personas mayores . Colaboración y Coordinación con servicios específicos y programas para personas mayores. . Oferta de recursos de adicciones especializados en pacientes crónicos y/o con deterioro cognitivo.
Tratar a personas usuarias de chemsex	. Protocolo específico de intervención con personas usuarias de chemsex . Adaptación de los recursos de apoyo al tratamiento con programa específico . Intervención terapéutica utilizando recursos y talleres específicos. . Colaboración con entidades y asociaciones LGTBIQ+ para información de la red, difusión e intervención conjunta. . Formación continua de profesionales y adquisición de competencias culturales LGTBIQ+ . Coordinación con el Centro de especialidades médicas de Montesa para la captación y/o derivación de los pacientes . Promover estrategias de atención en proximidad
Facilitar la integración sociorrelacional y laboral de pacientes mediante actividades dirigidas al desarrollo de sus habilidades sociales, culturales, formativas y laborales.	
Favorecer la integración social de las personas atendidas con criterios de normalización y adaptado a las necesidades sociales propias de cada persona	. Establecer un marco de comunicación y de coordinación estable con los Servicios Sociales Generales para la adecuada intervención social de las personas más vulnerables. . Difusión e intercambio de información sobre los programas y servicios de ambas redes . Potenciar la colaboración y participación con otras áreas del ayuntamiento, así como instituciones, recursos y entidades del tercer sector que apoyen la integración social.
Favorecer la integración laboral de las personas en tratamiento y adaptada a las necesidades sociolaborales de cada persona	. Optimización del Servicio de Orientación Laboral (SOL) con criterios de calidad . Intensificar acciones para aumentar la empleabilidad de los pacientes con menos recursos de empleo, poniendo el acento en las mujeres y en los mayores de 45 años y/o cronificados . Acciones que permitan dar continuidad a la línea de trabajo de empleo protegido. . Desarrollo de acciones formativas prelaborales . Mantener e intensificar la coordinación con la Agencia de Empleo, para diseñar programas de empleo protegido y favorecer la inclusión de las personas usuarias en su oferta formativa y laboral . Refuerzo de la coordinación con otras instituciones y recursos normalizados que apoyen la integración social y laboral

	. Implementar monográficos de integración social y laboral en todo el circuito de tratamiento a nivel individual y grupal . Desarrollo del Programa Salud e Integración
Favorecer la integración social de las personas con problemas judiciales asociados a una problemática adictiva mediante una atención especializada, durante el proceso jurídico penal, tanto a las personas afectadas como a sus familiares.	. Programa de atención y mediación en el ámbito judicial en relación con las adicciones. SAJIAD . Asesoramiento e información a pacientes y familias sobre medidas de resocialización, medidas alternativas a la prisión, régimen abierto, liberados condicionales, y cualquier otra medida de reinserción social. . Refuerzo de la coordinación con instituciones judiciales y penitenciarias . Impulsar y mejorar la formación de profesionales en las materias jurídicas y penitenciarias
Facilitar la integración socio relacional de las personas en tratamiento atendiendo sus necesidades de ocio.	. Revisión y actualización del Programa de integración social a través del ocio . Desarrollo del Programa de integración social a través del ocio dirigido. . Refuerzo de la colaboración con otras áreas municipales, así como instituciones, recursos y entidades que trabajen el ocio normalizado para facilitar el acceso de las personas en tratamiento . Impulso de acciones de voluntariado para mejorar la integración socio relacional.
Garantizar la existencia de una red de dispositivos hospitalarios y residenciales terapéuticos de apoyo al tratamiento integral.	
Potenciar recursos especializados en apoyo al tratamiento integral	. Oferta de Recurso especializado hospitalario en Tratamiento de la patología dual . Oferta de Recurso hospitalario de desintoxicación . Oferta de plazas en Centro de día para jóvenes y adolescentes . Oferta de Plazas en Comunidad terapéutica . Oferta de Plazas de piso de apoyo al tratamiento . Oferta de Plazas pisos de reinserción
Optimizar la utilización de los recursos de apoyo al tratamiento y a la reinserción	. Revisión de los perfiles de los/as usuarios/as para ingresar en los recursos . Revisión de los criterios de ingreso preferente
Mantener, supervisar y garantizar la calidad de los recursos existentes	. Sistema de Gestión de listas de espera de cada recurso . Revisión periódica de Informes e indicadores de calidad de cada recurso . Revisión periódica de encuestas de satisfacción . Actualización periódica del Proceso de Coordinación de Recursos de la Red . Visitas y reuniones periódicas del personal de los CAD . Revisión periódica de los criterios de derivación y de alta terapéutica

Potenciar las actuaciones específicas de tratamiento integral para mujeres.	
Identificar y reducir las brechas que impiden o dificultan el acceso de las mujeres a la atención y el tratamiento en los CAD y romper el estigma de las mujeres con adicciones.	. Acciones para mejorar la identificación de las brechas de género en el acceso a la red del Instituto de Adicciones . Acciones para mejorar la detección proactiva de mujeres con adicciones . Acciones de difusión de centros y servicios del Instituto de Adicciones específicos para mujeres. . Implementación de medidas que favorezcan la conciliación familiar como la citación preferente para mujeres en determinadas bandas horarias . Información, sensibilización y formación en mujer y adicción a otras redes de atención sociosanitaria que atienden a mujeres
Ofrecer a las mujeres con adicciones una intervención integral, de calidad y basada en la evidencia adaptada a sus necesidades.	. Actualización sobre género a profesionales de la red . Elaboración de la «Guía práctica para la realización del grupo de mujeres en los CAD». . Difusión de buenas prácticas en relación con la intervención específica con mujeres con adicciones . Actualización de la Intervención especifica individual y grupal . Impulso de la coordinación con Atención Primaria para la atención a mujeres con abuso de psicofármacos
En el documento original falta este objetivo operativo.	Actividades de ocio específica para mujeres Actividades formativas y de empleo específicas para mujeres
Fomentar programas específicos en todos los recursos de la red: reducción del daño, apoyo al tratamiento y reinserción	Puesta en marcha de recurso residencial de tratamiento exclusivo para mujeres con adicciones Programas específicos para mujeres en recursos de reducción del daño, apoyo al tratamiento y a la reinserción. Colaboración en la atención de las mujeres con adicciones en los recursos de la red SH y en los exclusivos para mujeres
Aumentar la colaboración y coordinación con recursos que atienden específicamente mujeres y con la red de atención a víctimas de violencia de género	Elaboración de protocolo de Colaboración con los Espacios de Igualdad Elaboración de Protocolo de derivación y coordinación de Violencia de Género
Ofrecer intervención a las personas sin hogar con adicciones en la red del Instituto de Adicciones y en la red de atención a las personas sin hogar.	
Garantizar a las personas con adicción sin hogar una atención adaptada a sus necesidades específicas.	. Actualización del protocolo de intervención en los CAD de personas sin hogar . Formación continua, sesiones clínicas o buenas prácticas . Actualización y refuerzo de la intervención terapéutica en adicciones que tenga en cuenta las propias características de las Personas Sin Hogar. . Refuerzo de intervenciones de prevención, promoción y detección de patologías, tanto físicas como psíquicas que tenga en cuenta las propias características de las Personas Sin Hogar. . Ayudas económicas para proporcionar a las personas con problemas de adicciones en proceso de tratamiento y en situación de exclusión social, los recursos mínimos necesarios para la realización de los programas (trasporte, objetos de higiene...).

	. Recursos específicos de apoyo al tratamiento y reinserción para personas sin hogar
Ofrecer intervención a las personas sin hogar con adicciones in situ en la red de atención a las personas sin hogar.	. Acciones para asesorar y reforzar (esto último en el caso de rebrote de la Covid-19) de la atención sanitaria en los centros de la red de atención a personas sin hogar: • Revisión de los protocolos actuales frente a la Covid-19 y envío periódico a todos los centros de la red SH. • Revisión y actualización de los circuitos de aislamiento. • Motivación y apoyo a la vacunación . Acciones para potenciar los programas de Educación para la Salud en todos los dispositivos y nuevos programas de detección de patologías, tanto físicas como psíquicas: • Elaboración y difusión de materiales de educación para la salud adaptadas a las necesidades de las personas sin hogar • Acciones para mejorar el acceso de las personas sin hogar a los Centros de Atención Primaria de Salud y atención especializada. • Formación de agentes de salud en los centros de la red de atención a personas sin hogar • Información, prevención y detección de hepatitis C y HIV y otras ITS • Talleres para mejorar las competencias digitales para que puedan realizar gestiones sociosanitarias. . Acciones para potenciar y desarrollar las intervenciones de reducción del daño del alcoholismo y otras adicciones en los centros de la red de atención a personas sin hogar
Promover la coordinación general y colaboración entre los recursos de la red de atención y la red de atención a PSH	. Actualización y difusión del Procedimiento para la atención a personas sin hogar con adicciones. . Acciones dirigidas a la difusión del trabajo y el conocimiento de los centros de las dos redes . Establecer los criterios para ingreso preferente de personas con adicciones en los recursos de la red de atención a las personas sin hogar. . Análisis de necesidades promovidas por comisión sin hogar del Foro técnico de adicciones y en el Foro sin Hogar (AG de Familias, Igualdad y Bienestar Social). . Coordinación en la Comisión de trabajo Inclusión social y Trabajo comunitario del Convenio entre el AG de Familias, Igualdad y Bienestar Social y el Organismo Autónomo Madrid Salud
Ofrecer a las familias de las personas con adicciones la atención, el apoyo y la orientación necesarios.	
Ofrecer a las familias de las personas en tratamiento una intervención que facilite el proceso terapéutico y el manejo de la adicción	. Intervención individual con los familiares de la persona con adicciones . Intervención grupal con las familias . Intervención terapéutica con familias y pacientes
Ofrecer orientación y estrategias a las familias de personas con problemas de adicción que no están en tratamiento	Atención a las familias de personas con problemas de adicción en recursos de apoyo al tratamiento y la reinserción

Mejorar la funcionalidad familiar.	. Jornadas dirigidas a familias y pacientes . Derivación a FERMAD de aquellas familias que necesitan una intervención más intensiva o prolongada en el tiempo

3.8.- ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA ADICCIÓN AL JUEGO.

El Instituto de Adicciones se compromete en este Plan a prevenir y a atender el trastorno por juego de azar y videojuegos. Para ello, garantiza llevar a cabo las acciones que le corresponden y que están recogidas en la **Estrategia Municipal de atención y prevención de la adicción al juego** aprobada por Junta de gobierno el 3 de marzo de 2022, de forma que se ofrezca un abordaje coordinado de este problema de salud pública.

Prevenir las conductas de riesgo y adicción al juego y a los videojuegos mediante la sensibilización y otras actividades preventivas.	
Prevención y concienciación a través de los diferentes recursos del Ayuntamiento para los colectivos de menores de 25 años	. Prevención de las adicciones a través de Internet y presencia en redes sociales del Servicio PAD . Espacio joven de prevención de las adicciones a través del ocio en distrito de San Blas. . Nuevo espacio joven en distrito de Villaverde de prevención de las adicciones en entorno comunitario. . Difusión de las acciones de sensibilización a la ciudadanía: sobre los problemas con videojuegos y juegos de azar a través del Programa: «LA CONTRAPARTIDA». (redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok y Youtube). . Realización de acciones de sensibilización en relación al juego por parte del Equipo de Educación Social. . Desarrollo de un proyecto de colaboración con la Consejería de Educación CM para formar a profesorado, concienciar a alumnado de 5º y 6º de primaria y ESO e informar a las AMPAS sobre los riesgos asociados a las adicciones, incluyendo el juego y el uso abusivo de pantallas, redes sociales y videojuegos . Detección precoz de adolescentes y jóvenes que presentan indicadores de riesgo de trastorno por juego de azar y/o apuestas deportivas) y videojuegos . Asesoramiento especializado a personas en riesgo y sus familias a través del Servicio de Orientación Familiar (SOF)
Prevención y concienciación a través de los diferentes recursos del Ayuntamiento para los colectivos de mayores de 25 años	. Actuaciones de prevención dirigidas al personal del Ayuntamiento de Madrid en el marco de las actuaciones desarrolladas con Salud Laboral . Actuaciones de prevención dirigidas a personas de recursos y entidades sociales de la ciudad de Madrid. . Asesoramiento especializado a personas en riesgo y sus familias a través de los equipos profesionales de los 7 Centros de Atención a las Adicciones (CAD).
Formar a profesionales de educación, mediadores y agentes sociales	. Formación a través del Aula de Formación a Distancia del Servicio PAD Madrid Salud que ofrece Cursos de Formación Especializada, con certificación universitaria. . Desarrollo de un programa de «FORMADOR DE FORMADORES» para alinear y coordinar los mensajes y contenidos impartidos por las diferentes áreas.

Tratamiento integral y especializado a las personas afectadas y sus familias.	
Ofertar tratamiento integral y especializado a las personas con trastorno por juego	. Tratamiento integral ambulatorio, en los siete Centros de Atención a las Adicciones y, en su caso ingreso en recursos de apoyo al tratamiento y a la reinserción y/o en la red de Salud Mental . Creación de un grupo de trabajo para establecer acciones de coordinación con objeto de detectar entre la población usuaria de recursos sociales a personas afectadas y derivar a los programas y servicios de Madrid Salud (Instituto de Adicciones) . Colaboración a través de convocatorias de subvenciones con Entidades Sociales para prevención, apoyo al tratamiento y reinserción de adicciones. . Fomento de la inserción a través de talleres pre-laborales y servicio de orientación laboral (SOL) dirigidos a la población afectada. . Adaptación de los recursos de apoyo al tratamiento y a la reinserción del Instituto de adicciones (centro de patología dual, comunidades terapéuticas y recursos residenciales) . Refuerzo del equipo de tratamiento de los CAD con incorporación profesionales para atender a personas afectadas . Línea de coordinación y colaboración con la red de Salud mental de la CM.
Atención e intervención a las familias de las personas con trastorno por juego	. Intervención terapéutica familiar a través de los equipos de los CAD
Actuaciones específicas sobre zonas más vulnerables.	
Atender a las zonas con más incidencia	. Desarrollo del programa de prevención e intervención temprana ante los riesgos del juego de azar: «La contrapartida» con acciones de sensibilización, acciones para dotar a los adolescentes y jóvenes con herramientas preventivas que sirvan para disminuir la intención de juego y evitar conductas de riesgo, así como acciones con personas adultas de referencia en los distritos de Latina, Carabanchel, Usera y Tetuán . Realización de la fase II del programa de prevención e intervención temprana ante los riesgos del juego de azar: «La contrapartida» en los distritos: Latina, Carabanchel, Usera, San Blas, Moratalaz, Villa de Vallecas, Villaverde. Vicálvaro, Puente de Vallecas, Tetuán, Centro y Ciudad Lineal. . Realización de la fase III del programa de prevención e intervención temprana ante los riesgos del juego de azar: «La contrapartida» en los distritos de Fuencarral, Chamartín, Moncloa, Barajas, Chamberí, Salamanca, Retiro, Arganzuela y Hortaleza

3.9.- COORDINACIÓN Y TRABAJO EN RED.

El Instituto de Adicciones se compromete a llevar a cabo las labores para unir, conectar y concertar a todos los elementos participantes, y sus acciones, necesarios en la intervención de las adicciones.

Desarrollar y mejorar las estrategias de coordinación con los grupos de interés.	
Impulsar la coordinación con las redes internacionales en materia de adicciones	. Participación del Instituto en foros internacionales. . Realización de actividades informativas/visitas con entidades internacionales
Desarrollar líneas permanentes de coordinación en materia de adicciones con el Plan Nacional sobre Drogas y con la Federación Española de Municipios y Provincias.	. Participación en acciones formativas auspiciadas por el Plan Nacional sobre Drogas . Actualización de la información del IA en las páginas web del PNSD y de la FEMP. . Colaboración en estudios auspiciados por el PNSD
Impulsar la coordinación con la Comunidad de Madrid	. Colaboración con la Oficina Regional de Salud Mental en relación con el tratamiento de las adicciones . Colaboración con la Consejería de Educación para el desarrollo de programas preventivos en ámbito educativo . Coordinación con Atención primaria para la detección, captación y colaboración en los tratamientos
Desarrollar líneas de coordinación y del trabajo en red con otras áreas del Ayuntamiento de Madrid	. Comisiones de trabajo para poder implementar las medidas incluidas en los Acuerdos de la Villa a través del Convenio de colaboración entre el A.G de Familias, Igualdad y Bienestar social y Madrid Salud. . Coordinación con agentes tutores y SAMUR Protección Civil en actuaciones dirigidas a jóvenes y adolescentes . Desarrollo y seguimiento de las acciones que le corresponden en Opción Madrid-Estrategia municipal de atención y prevención de la adicción al juego. . Desarrollo, evaluación y seguimiento de recursos y programas, en determinados distritos, financiados a través de Planes de Reequilibrio Territorial . Coordinación con las Juntas de Distrito. . Cooperación a través del programa de inclusión social del convenio entre la Dirección General del Deporte y Deporte y Vida. . Coordinación con la Agencia para el Empleo
Apoyar al movimiento asociativo para el desarrollo de programas y recursos de prevención y de apoyo al tratamiento y a la reinserción en materia de adicciones.	. Convocatoria anual de Subvenciones. . Convenio subvención entre Madrid Salud y la Plataforma Madrileña de entidades para la asistencia a la persona adicta y su familia (FERMAD) para la potenciación del asociacionismo familiar en el campo de las adicciones. . Convenio subvención entre Madrid Salud y la Unión española de Asociaciones y Entidades de Atención al drogodependiente (UNAD), para el desarrollo de un programa de formación, investigación y sensibilización en el ámbito de las adicciones
Desarrollar líneas de Colaboración con universidades, colegios profesionales y sociedades científicas	. Colaboraciones con universidades, colegios profesionales . Colaboración sociedades científicas

Desarrollar líneas de coordinación y colaboración con la SG de Prevención y Promoción de Madrid Salud.	. Colaboraciones y coordinaciones con CMSc . Colaboraciones con las Unidades Técnicas de Apoyo Diagnóstico de Montesa, Unidad de Farmacia y Laboratorio de Análisis Clínicos
Desarrollar las funciones de coordinación del Foro Técnico de Adicciones.	
Propiciar las funciones de coordinación del del Foro Técnico de Adicciones	. Reuniones plenarias . Reuniones grupos de trabajo de las cinco comisiones

3.10.- CALIDAD Y MEJORA CONTINUA.

El Instituto de Adicciones se compromete a garantizar la calidad y la mejora continua de los servicios prestados, para lo que fundamenta su actividad en un estilo de trabajo innovador, un liderazgo participativo, la implicación del personal y la orientación al servicio y la satisfacción de la ciudadanía.

Garantizar y potenciar la calidad en todos los niveles de la organización, actualizando y evaluando los procesos y los servicios prestados mediante el establecimiento de indicadores de gestión y estándares de calidad.	
Cumplir las actuaciones del Plan Operativo de Gobierno 2019/23 y sucesivos	. Desarrollo de las cinco actuaciones POG 2019/23 . Desarrollo de las actuaciones encomendadas en sucesivos planes de gobierno . Seguimiento y notificación de los indicadores
Gestionar por procesos	. Actualización del mapa de procesos del IA . Análisis y formalización de nuevos procesos . Seguimiento, evaluación y mejora de los procesos
Mantener actualizado el CMI de forma continua	. Seguimiento mensual, trimestral y anual, del cuadro de Mando Integral . Seguimiento de los indicadores del CMI según la frecuencia establecida (mensual, trimestral o anual) . Revisión/actualización de los indicadores del CMI
Implementar elaboración y revisión de buenas prácticas	. Elaboración de documentos sobre buenas prácticas, metodologías de trabajo, herramientas de calidad y mejora. . Elaboración y actualización de las guías clínicas, protocolos y procedimientos
Garantizar la seguridad clínica	. Diseño e implantación de un sistema de gestión de riesgos para la seguridad de pacientes en los Centros de Atención a las Adicciones . Seguimiento de los indicadores establecidos en el Sistema de gestión de riesgos
Cumplir con los compromisos del sistema del Sistema de Sugerencias y Reclamaciones de Madrid Salud	

Sensibilizar al personal del Instituto de Adicciones en los compromisos y acciones de calidad	. Acciones formativas e informativas a la plantilla en relación con los compromisos de calidad del Instituto de Adicciones
Fomentar un entorno seguro para la plantilla	. Cumplimiento del protocolo de agresiones de terceros . Cumplimiento del procedimiento de derivación de casos conflictivos
Elaborar memoria anual	. Recogida de información y elaboración del documento . Seguimiento y análisis de los resultados de los indicadores . Actualización del sistema de registro de indicadores
Evaluar los resultados de la intervención con las personas usuarias	. Consolidación del seguimiento postalta de las personas atendidas . Implantación de registro del Plan de tratamiento . Evaluación externa de la eficacia de los programas de prevención
Consolidar, ampliar y adaptar los instrumentos y sistemas de registro de la red del Instituto de Adicciones	. Revisión de los sistemas de recogida de información y los modelos de historia clínica . Elaboración de la cartera de proyecto anual Mantenimiento del Módulo Bussines Intellingent (BI)
Gestionar los servicios con eficacia y eficiencia, de forma participativa y transparente, mejorando de forma continua y rindiendo cuentas a la ciudadanía.	
Gestionar con efectividad los programas presupuestarios	. Elaboración anual del cumplimiento de los indicadores presupuestarios . Elaboración anual de memoria de cumplimiento presupuestario . Elaboración anual de la memoria de cumplimiento de los objetivos de igualdad
Mantener compromisos con la ciudadanía en relación con la calidad de los servicios prestados	Realización de Encuestas de Satisfacción de usuarios
Evaluar la evolución del cumplimiento de las acciones integradas en el Plan de Adicciones.	. Realización de informes de evaluación del Plan de Adicciones . Presentación de los informes de evaluación en el Plenario del Foro Técnico de Adicciones . Divulgación de los resultados
Cumplir el Plan de actuación anual	. Desarrollo de las actuaciones . Seguimiento de los resultados
Cumplir la carta de servicios	. Seguimiento de la carta de servicios . Mantenimiento y actualización de la carta de servicios

Potenciar el desarrollo del conocimiento: formación, investigación y docencia.	
Compartir conocimiento	. Organización de jornadas, foros, congresos y seminarios . Participación del personal en jornadas, foros, congresos y seminarios
Fomentar la formación continuada de la plantilla	. Detección de nuevas necesidades de formación . Elaboración de planes anuales de formación . Mantenimiento y dinamización del comité de formación.
Facilitar que la plantilla imparta docencia sobre adicciones	. Promoción para que el personal pueda participar como formadores/as en los planes de formación Promoción para que el personal pueda ejercer como profesorado en cursos de pregrado y posgrado Tutorización de alumnos/as de pregrado/posgrado/ Tutorización de PIR, MIR, EIR
Facilitar y promocionar la realización de investigaciones en el ámbito de las adicciones	Asesoramiento al personal en la realización de investigaciones y artículos. Actualización y dinamización del comité de investigación Colaborar con otras instituciones para realizar investigaciones en el ámbito de las adicciones
Compartir conocimiento	Organización de jornadas, foros, congresos y seminarios Participación del personal en jornadas, foros, congresos y seminarios

4.- LA CARTA DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE ADICCIONES: DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS USUARIOS. SERVICIOS PRESTADOS. COMPROMISOS CON EL CIUDADANO.

Fecha de aprobación: 8 de febrero de 2007

Fecha de certificación: 15 de diciembre de 2023

Fecha de última evaluación: 28 de marzo de 2023

Hace ya treinta años que el Ayuntamiento de Madrid da respuesta a los problemas relacionados con las adicciones de la ciudadanía madrileña. A través de un **modelo flexible y adaptado** a los distintos perfiles de personas que demandan asistencia, se han ido adaptando los diferentes recursos utilizados a lo largo del proceso de atención integral.

Las **líneas estratégicas de la red** se articulan en torno a la prevención de las adicciones, la atención integral de adolescentes y jóvenes, la reducción del daño y el tratamiento e integración social de personas adultas con adicciones. Se desarrollan acciones e intervenciones específicas dirigidas a las mujeres y a la prevención y detección de la violencia de género. Uno de los objetivos prioritarios es la sensibilización de la ciudadanía en relación con las adicciones y la reducción del estigma asociado a las adicciones, facilitando el conocimiento de las mismas y la accesibilidad de los centros y servicios.

Madrid cuenta con una red de **siete Centros de Atención a las Adicciones (CAD)** que desarrollan una atención interdisciplinar (biopsicosocial), poniendo el enfoque en las características de la persona que tiene una adicción o está en riesgo de desarrollarla, en vez de hacerlo en la sustancia que se consume o conducta problema. Se pone el énfasis con la persona en tratamiento en el consenso de su indicación terapéutica, con lo que se consigue mayor adherencia a las intervenciones.

Se ofrece **atención a las personas con identidades diversas** (orientación sexual, diversidad funcional, origen, cultura, idioma, etc.), de forma que se pueda dar una respuesta ajustada a sus necesidades, promoviendo paralelamente su integración social.

La red cuenta también con una serie de servicios de detección y captación que ponen el énfasis en los **colectivos más vulnerables**, con mayor dificultad de cambio o con más dificultades de acceso a la red, llevando a cabo programas de reducción del daño dirigidos a las personas con consumo activo.

Existen también recursos de apoyo al tratamiento y a la reinserción (pisos, plazas en comunidad terapéutica, centro de patología dual), y se realiza un esfuerzo muy importante para reinsertar a las personas atendidas, impulsando actividades formativas y pre laborales a través de un Servicio de Orientación Laboral específico.

Los servicios ofrecidos en esta red contribuyen a la consecución del **Objetivo de Desarrollo Sostenible** Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades de la **Agenda 2030** de la Ciudad de Madrid, en su meta "**Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol**".

4.1.- DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS USUARIOS.

4.1.1.- DERECHOS.

Además de los derechos de la ciudadanía recogidos básicamente en la normativa relativa a régimen jurídico de las Administraciones Públicas, procedimiento administrativo común, transparencia y protección de datos, todos los madrileños/-as tienen derecho:

- A **recabar información para la prevención** de las adicciones.
- A ser destinatarios/as de **acciones de prevención generales o específicas**.
- A **ser atendidos/as por los CAD en función de su necesidad**.

En particular, **las personas usuarias de los CAD de Madrid Salud y sus centros concertados**, según la **Ley 5/2002 de 27 de junio,** sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos de la Comunidad de Madrid, tienen derecho:

- A la igualdad de acceso a los dispositivos asistenciales y al respeto de su personalidad, dignidad e intimidad, sin que puedan ser discriminados/as por ninguna causa.
- A la asistencia, dentro de la red pública asistencial de la Comunidad de Madrid y de los centros privados concertados.
- A la información sobre los servicios y recursos a los que se puede acceder y los requisitos y exigencias que plantea su tratamiento.
- A recibir un tratamiento adecuado, prestado por centros y servicios acreditados, las diferentes ofertas terapéuticas reconocidas, con el pertinente asesoramiento técnico.
- A la voluntariedad para iniciar y cesar un proceso terapéutico, excepto en los casos señalados por la legislación vigente.
- A la confidencialidad de toda la información relativa a su proceso.
- A la información, verbal o por escrito, de su programa terapéutico individualizado.
- A la información adecuada, comprensible, verbal o, en su caso, escrita, en referencia a la medicación que se le prescriba en el proceso de tratamiento que esté siguiendo.
- A que se le extienda certificación gratuita acreditativa sobre su situación.

- A que quede constancia por escrito o en soporte técnico adecuado de todo su proceso asistencial.
- A ser advertido/a de si el tratamiento que se le aplique puede ser utilizado para un proyecto docente de investigación, que en ningún caso podrá comportar peligro adicional para su salud. En todo caso será imprescindible su previa autorización garantizándose que su negativa no implicará ningún tipo de discriminación, en lo relativo a su asistencia.
- A conocer el nombre y cualificación profesional de las personas encargadas de su asistencia, que deberán estar debidamente identificadas.
- A saber quién es la persona, personas, unidades o servicios a las que puede dirigirse para preguntar o plantear cuestiones o quejas, así como los mecanismos y vías para formular las mismas.
- A cesar en la utilización de los servicios o en la permanencia en el centro por voluntad propia. El ejercicio de este derecho podrá ser objeto de limitaciones de conformidad con lo establecido en la legislación vigente.
- A conocer la normativa del centro en lo que pueda afectarle.
- A la firma de un contrato terapéutico que explicite los derechos y deberes y contemple la eventual participación activa de la familia o responsable de cada usuario/a lo largo del proceso.

4.1.2.- RESPONSABILIDADES.

Las **obligaciones de las personas usuarias** de los CAD de Madrid Salud y sus centros concertados, según la Ley 5/2002 de 27 de junio sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos de la Comunidad de Madrid, son:

- Cumplir todas las especificaciones e indicaciones que, a lo largo del programa de tratamiento, voluntariamente aceptado, se le indiquen.
- Respetar las normas de funcionamiento interno de cada centro, servicio o establecimiento asistencial y de integración que previamente le hayan sido comunicadas.
- Someterse a las determinaciones toxicológicas que le sean indicadas, en el momento en que se le señalen.
- Firma de la baja voluntaria en caso de negativa al tratamiento o abandono de la atención.
- Responder a las cuestiones que, respetando sus derechos como persona, le sean planteadas en el curso de su tratamiento o proceso de integración.
- Tratar con respeto a todo el personal del centro y a los demás usuarias/os del servicio, evitando las conductas agresivas hacia los mismos y colaborando en el buen mantenimiento de las instalaciones.
- Observar una conducta basada en el mutuo respeto, tolerancia y colaboración, encaminada a facilitar una mejor convivencia.

4.2.- SERVICIOS PRESTADOS.

SERVICIO DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES (PAD).

Ofrece **información, formación y orientación** (criterios y pautas de actuación) **en materia de prevención de adicciones de manera personalizada y confidencial**, tanto en formato presencial como online. Se dispone de un aula de formación online desde la que se accede a Cursos de Formación (con certificación académica) dirigidos a estudiantes y profesionales; así como a Módulos Informativos monográficos dirigidos a la ciudadanía.

El **Servicio de Orientación familiar (SOF)** se dirige a **familiares de adolescentes y jóvenes menores de 25 años**. Este servicio lleva a cabo un **Programa de Orientación Familiar** personalizado, de fácil acceso mediante teléfono y redes sociales, que consiste en intervenciones presenciales individuales y/o grupales.

REDUCCIÓN DEL DAÑO.

El objetivo principal es la **detección y captación de personas con adicciones que no acceden fácilmente a los centros de tratamiento ambulatorio**, proporcionando orientación, información y una intervención social y/o sanitaria básica inmediata a dichas personas. Se presta a través de:

- El **Centro de Atención Socio Sanitaria Básica (CAB),** dirigido a pacientes drogodependientes en riesgo de exclusión social.
- La **Unidad Móvil Madroño**, dispositivo móvil de tratamiento dirigido a la reducción de daño en drogodependientes en situación de exclusión social.
- El **Programa Istmo**, servicio de atención y mediación intercultural dirigido a personas de origen extranjero con adicciones.

ATENCIÓN INTEGRAL.

En los **Centros de Atención a las Adicciones (CAD),** se realiza una valoración biopsicosocial del/la paciente, que tiene como objetivo la realización de un diagnóstico de adicción y el establecimiento de unas metas, consensuadas, adaptadas a la persona y al momento en el que se encuentra tanto a nivel biológico, psicológico y social. Se ofrece atención y tratamiento a cada persona con adicción y su familia de manera individualizada, contemplando sus aspectos médicos, psicológicos, sociales y familiares, destinada a reducir o extinguir los efectos nocivos de dicha adicción y conseguir mejoras en su estado de salud, favoreciendo su plena integración social.

El 100% de los CAD contarán con la acreditación como Centro Sanitario de la Comunidad de Madrid.

SERVICIO DE ORIENTACIÓN LABORAL –SOL.

Programas y recursos dirigidos a lograr una adecuada **integración laboral**: tras la valoración del nivel de empleabilidad de las usuarias/os, se ofrece información, orientación y asesoramiento sobre actividades y recursos dirigidos al empleo; intermediación con recursos formativos y de empleo; acciones formativas; itinerarios personalizados de inserción y bolsa de empleo.

RECUROS RESINDENCIALES DE APOYO AL TRATAMIENTO Y LA REINSERCIÓN.

Aunque el tratamiento se presta fundamentalmente en los CAD, que son centros ambulatorios, en ocasiones la atención prestada debe complementarse con la **utilización de recursos residenciales de apoyo al tratamiento** para aquellas personas que presentan necesidades especiales y que precisan de mayor contención e intensidad asistencial y, por tanto, requieren la utilización temporal de un centro residencial.

Se dispone de un Centro Hospitalario de Patología Dual, plazas en Comunidades Terapéuticas y diferentes pisos de apoyo al tratamiento y a la reinserción adaptados a los perfiles de pacientes más vulnerables. La derivación a estos recursos se realiza desde el CAD de referencia de cada paciente.

INFORMACIÓN.

▪ Informar sobre las cuestiones generales relacionadas con los servicios prestados.

▪ Informar sobre el estado y tramitación de los expedientes relacionados con la atención a las adicciones (peticiones, autorizaciones administrativas, responsabilidad patrimonial...).

SUGERENCIAS, RECLAMACIONES Y FELICITACIONES.

▪ Gestionar las sugerencias, reclamaciones y felicitaciones remitidas por la ciudadanía.

▪ Informar sobre su estado de tramitación.

4.3.- COMPROMISOS CON EL CIUDADANO.

COMPROMISO 1

Realizamos en el Servicio de Prevención de Adicciones (PAD) la puesta en marcha de la intervención de orientación familiar demandada en cada caso, en función del análisis de necesidades previo y los recursos disponibles en cada momento, garantizando que al menos el 90% de las personas usuarias sean atendidas por un/a profesional en un plazo máximo de 7 días naturales desde la acogida inicial, y que el restante 10% sea atendido en un plazo máximo de 10 días naturales.

- Indicador 1.1. Porcentaje de personas usuarias atendidas en 7 días naturales.
- Indicador 1.2. Porcentaje de personas usuarias atendidas 10 días naturales.

COMPROMISO 2

Prestamos los servicios en horario de mañana y tarde, en instalaciones con un tamaño, señalización exterior e interior, orden, limpieza, confort y equipamiento que garantizan la intimidad y confidencialidad en la atención. La valoración media otorgada por las personas usuarias será superior a 3,6 en una escala de 1 a 5, logrando que al menos un 90% de las personas usuarias estén satisfechas (puntuación de 4 o 5) **con las instalaciones y que el porcentaje de las personas nada satisfechas** (puntuación de 1 o 2) **no supere el 5%. El compromiso afecta a todos los centros del Instituto de Adicciones.**

- Indicador 2.1. Valoración media de la limpieza de las instalaciones.
- Indicador 2.2. Porcentaje de personas usuarias satisfechas globalmente con la limpieza de las instalaciones.
- Indicador 2.3. Porcentaje de personas usuarias nada satisfechas con la limpieza.
- Indicador 2.4. Valoración media de la comodidad de las instalaciones.
- Indicador 2.5. Porcentaje de personas usuarias satisfechas globalmente con la comodidad de las instalaciones
- Indicador 2.6. Porcentaje de personas usuarias nada satisfechas con la comodidad.
- Indicador 2.7. Valoración media de las condiciones de confidencialidad facilitadas por las instalaciones.

- Indicador 2.8. Porcentaje de personas usuarias satisfechas globalmente con la confidencialidad facilitada por las instalaciones.
- Indicador 2.9. Porcentaje de personas usuarias nada satisfechas con la confidencialidad.

COMPROMISO 3

Realizamos la puesta en marcha del programa terapéutico en función del análisis de necesidades previo y los recursos disponibles en cada momento, garantizando que al menos el 80% de las personas serán atendidas por un/a profesional en un plazo máximo de 15 días naturales desde la acogida inicial, y que no más de un 2% sea atendido en un plazo superior a 30 días naturales.

- Indicador 3.1. Porcentaje de las solicitudes atendidas en un plazo máximo de 15 días naturales.
- Indicador 3.2. Porcentaje de solicitudes atendidas en un plazo máximo de 30 días naturales.
- Indicador 3.3. Tiempo medio de espera de los/as usuarios/as por servicio prestado.

COMPROMISO 4

Atendemos con profesionales con alta cualificación, y de forma ágil, proporcionando un trato amable y cortés utilizando un lenguaje claro y comprensible, garantizando una atención individualizada y personalizada. La valoración otorgada por las personas usuarias será superior a 3,6 puntos en una escala de 1 a 5, al menos un 90% de las personas usuarias estarán satisfechas con dicha atención y el porcentaje de las personas nada satisfechas no superará el 5%.

- Indicador 4.1. Valoración media del trato recibido por parte del personal.
- Indicador 4.2. Porcentaje de personas usuarias satisfechas globalmente con el trato recibido por parte del personal.
- Indicador 4.3. Porcentaje de personas usuarias insatisfechas con el trato recibido por parte del personal.
- Indicador 4.4. Valoración media de la agilidad para atender y resolver problemas del personal de recepción.
- Indicador 4.5. Valoración media de los conocimientos de los profesionales y la capacidad para ayudarles en su proceso de recuperación.

COMPROMISO 5

Nos comprometemos a ofrecer a la plantilla de los CAD formación continua y de calidad. La media anual de horas de formación de la plantilla será como mínimo de 30, siendo la valoración de la formación restringida organizada por el Instituto de Adicciones a través de la Escuela de Formación del Ayuntamiento de Madrid superior a un 8 en una escala de 0 a 10 de media.

- Indicador 5.1. Horas de formación continua a la plantilla.
- Indicador 5.2. Valoración media de la plantilla de la formación restringida.

Compromiso 6

Garantizamos la dotación y cobertura al menos de un 95% de una plantilla conformada por profesionales pertenecientes a las áreas sanitaria, psicológica, social y ocupacional, de forma que se asegure la continuidad de los programas terapéuticos así como la atención integral de las personas con adicciones usuarias de la red

- Indicador 6.1. Porcentaje de plantilla cubierta.

Compromiso 7

Prestamos un servicio global de calidad, logrando que al menos un 90% de las personas usuarias estén satisfechas con el servicio recibido, y que el porcentaje de las nada satisfechas.

- Indicador 7.1. Porcentaje de personas usuarias satisfechas.
- Indicador 7.2. Porcentaje de personas usuarias nada satisfechas.

Compromiso 8

Garantizamos la calidad de los tratamientos recibidos en la red de recursos terapéuticos residenciales de asistencia y reinserción. La valoración otorgada por las personas usuarias será superior a 3,6 puntos en una escala de 1 a 5.

- Indicador 8.1. Valoración media del tratamiento recibido en los recursos terapéuticos residenciales de asistencia y reinserción.

Compromiso 9

El Servicio de Orientación Laboral (SOL) garantiza que al menos el 95% de las personas usuarias inicien su itinerario personalizado de inserción en un plazo máximo de 7 días naturales desde la fecha de la demanda, y que el 5 % restante comience dicho itinerario en un plazo máximo de 15 días.

- Indicador 9.1. Porcentaje de personas usuarias atendidas en un plazo máximo de 7 días naturales.
- Indicador 9.2. Porcentaje de personas usuarias atendidas en un plazo máximo de 15 días naturales.

Compromiso 10

El Servicio de Orientación Laboral (SOL) presta un servicio global de calidad, logrando que al menos un 80% de las personas usuarias estén satisfechas con el servicio recibido, y que el porcentaje de las personas nada satisfechas no supere el 5%.

- Indicador 10.1. Porcentaje de personas usuarias del SOL satisfechas.
- Indicador 10.2. Porcentaje de personas usuarias del SOL insatisfechas.

Compromiso 11

El Servicio ISTMO presta atención por parte de profesionales con cualificación, garantizando que al menos el 95% de las personas usuarias sean atendidas en un plazo máximo de 7 días naturales desde la acogida inicial y que el restante 5% sea atendido en un plazo máximo de 15 días naturales.

- Indicador 11.1. Porcentaje de personas usuarias atendidas en 7 días naturales.
- Indicador 11.2. Porcentaje de personas usuarias atendidas en 15 días naturales.

Compromiso 12

El Centro de Atención Socio Sanitaria Básica (CAB), presta atención en horario nocturno por parte de profesionales con cualificación, garantizando que al menos el 95% de las personas usuarias sean atendidas en las primeras 24 horas desde la acogida inicial, y que el restante 5% sean atendidas en un plazo máximo de 48 horas.

- Indicador 4.1. Porcentaje de personas usuarias atendidas en las primeras 24 horas.
- Indicador 4.2. Porcentaje de personas usuarias atendidas en un plazo máximo de 48 horas.

Compromiso13

La Unidad Móvil Madroño presta atención por parte de profesionales con cualificación, garantizando que al menos el 95% de las personas usuarias sean atendidas en las primeras 24 horas desde la acogida inicial, y que el restante 5% sea atendido en un plazo máximo de 48 horas.

- Indicador 5.1. Porcentaje de personas usuarias atendidas en las primeras 24 horas.
- Indicador 5.2. Porcentaje de personas usuarias atendidas en un plazo máximo de 48 horas.

Compromiso 14

Contestamos el 60% de las sugerencias, reclamaciones y felicitaciones como máximo en 30 días naturales y en ningún caso en un plazo superior a 2 meses.

- Indicador 13.1. Sugerencias, reclamaciones y felicitaciones relativas a los servicios prestados por el Instituto de Adicciones. Indicador informativo.
- Indicador 13.2. Porcentaje de sugerencias, reclamaciones y felicitaciones relativas a los servicios prestados por el Instituto de Adicciones contestadas como máximo en 30 días.
- Indicador 13.3. Porcentaje de sugerencias, reclamaciones y felicitaciones relativas a los servicios prestados por el Instituto de Adicciones contestadas en 2 meses.

Bibliografía

. Ley 5/2.002, de 27 de junio sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos de la Comunidad de Madrid.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-14844

. Plan de Adicciones de la Ciudad de Madrid. 2.022-2.026.

https://transparencia.madrid.es/FWProjects/transparencia/PlanesYMemorias/Planes/MadridSalud/Ficheros/PlanAdicciones2022_2026.pdf

. La Carta de Servicios del Instituto de Adicciones.

https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Calidad/CARTAS%20SERVICIOS/SistemaCartasServicio/13%20CS_InstAdicMadridSalud/Definitiva/CS_%20InstitutoAdicciones-Nov23.pdf